

Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix

MER · KLINIK · RAUM · PHILOSOPHIE · FUSION HERO OS

v10.0.0 — additive Evolution über das v7-Kompendium (vollständig erhalten)

Fusion Hero OS Team

BCG v7 + Fusion Hero OS · 2026-07 · Ausführliche MER-Fassung

Teil I · MER und klinische Grundlegung

Teil II · Raum, Erklärung und Lösung

Teil III · Mathematik, Informatik, Neurotheologie

Teil IV · Visualisierung und Trajektorien

Teil V · Dissertation und heroische Philosophie

Teil VI · Heroismus Edition und Gesamtarchitektur

Inhalt

Einordnung nach Ursachdimension — MER · KLINIK · RAUM · PHILOSOPHIE · FUSION HERO OS
BCG — Backward Compatibility Guarantee
v10-Synthese-Erweiterung: Vier Organe, eine Verfassung
Was v10 zusätzlich leistet (ohne v7 zu ersetzen)
Was v10 weiterhin *nicht* leistet
Architektur v10 (erweitert)
Axiome I–IV auf die 4D-Matrix abgebildet
30.1 I(Z) und Axiom I
30.2 Axiom II und K-primäre Pfade
30.3 Axiom III und memetische vs. mimetische Heilung
30.4 Axiom IV und Trajektorien
Autopoiesis der klinischen Erkenntnis
Autopolitik: wer darf klinische Zustände wohin legen?
Module und Dateien (ehrliche Landkarte)
Consent & PII (Stage-A/B)
QUBO-Triage und Cluster
Erweiterte Gesamtpipeline (v7 §28 + v10)
Proof-Honesty-Kreuztabelle (Auswahl)
Störungen × v10-Werkzeug (Erweiterung zu §19.3)
Kliniker-Checkliste (5 Minuten)
Glossar-Erweiterung v10
Publikations- und Editionsvermerk v10.0.0
Schlusswort v10
Einordnung nach Ursachdimension — MER · KLINIK · RAUM · PHILOSOPHIE
Synthese: Drei Ebenen als ein Organismus
Vorbemerkung: Was diese Matrix leisten soll — und was nicht
Zur Architektur dieses Bandes
Einordnung nach Ursachdimension (Körper · Geist · Seele · Natur) mit imaginärem Raum
Abgrenzung & klinische Hygiene
Übersichtsmatrix (24 Störungen + Evidenz-Schwerpunkt)
Korrekturen gegenüber v1 (wissenschaftlich)
Der imaginäre Raum nach Dimension
Cluster nach Primärursache
3.1 N-primär (Natur-bedingt: genetisch, neurologisch, konstitutionell)
3.2 S-primär (Seele-bedingt: Bindung, Trauma, Beziehung)
3.3 G-primär (Geist-bedingt: kognitive Muster, Bewertung, Denken)
3.4 K-primär (Körper-bedingt: somatisch, autonom, biochemisch)
Kongruenz mit dem Werk
Grenzen des Modells (präzisiert)
Komorbiditäts-Interaktionsmatrix (neu)
Neurobiologische Pfade (kompakt, evidenzorientiert)
Therapiepfade nach Cluster (Leitlinien-Nähe)
Ethik, Stigma & Sprache
Memetisch/Mimetisch-Kongruenzen
6.1 Matrix: Störung × Qualität × Beispiel
6.2 Memetische vs. mimetische Heilung
6.3 Regel
Der psychiatrische Raum: Geometrie der 4D-Matrix
11.1 Koordinatensystem

- 11.2 Der imaginäre Raum als Schattenhülle
- 11.3 Raumregionen (Octanten)
- 11.4 Trajektorien $Z(t)$

Raumkarte: 24 Störungen als Koordinaten

Vertiefende Erklärungen

- 13.1 N-Achse: Wenn die Konstitution die Bühne setzt
- 13.2 S-Achse: Bindung als Gravitationsfeld
- 13.3 G-Achse: Das Meta-Instrument und sein Blindspot
- 13.4 K-Achse: Der Körper als ehrlicher Zeuge — oder als Bühne
- 13.5 Schlüsselstörungen — Integrative Erklärung

Lösungsansätze vertieft (rekonstruktiv)

- 14.1 Dreiphasen-Modell (gilt für alle Cluster)
- 14.2 Lösungsmatrix nach Störung
- 14.3 Cluster-spezifische Rekonstruktionspfade
- 14.4 $I(Z)$ -Senkung: praktische Übungen (MER)
- 14.5 Memetisch vs. mimetisch — Entscheidungsbaum

Bewegungsgesetze & Prognose im Raum

Heroische Mathematik: $\psi \leftrightarrow Z$ im epistemischen Raum ■

- 16.1 Isomorphie $MER \leftrightarrow \blacksquare$
- 16.2 Habituation mit Umkehr: $\psi \blacksquare \phi$ als Therapieoperator
- 16.3 Zwei Zeitdimensionen in der Therapie
- 16.4 $q1b1 \leftrightarrow b2q2$ und Störungsprofile
- 16.5 Ghost Fixing und Geister-Fixierung
- 16.6 Stabilitäts-Gradient und Heilungsprognose

Heroische Informatik: Informationsarchitektur der Störung

- 17.1 Layer-Stack als Behandlungsarchitektur
- 17.2 Δ als Kodierungsfehler
- 17.3 $q \blacksquare b$ -Routing pro Cluster
- 17.4 QUBO-Triage: welche Achse zuerst?
- 17.5 Bidirektionale Suche = Therapiefad-Exploration
- 17.6 Geltungsstand der v4-Brücken (FormalMathematics)

Einordnung nach Ursachdimension — MER · KLINIK · RAUM · PHILOSOPHIE · FUSION HERO OS

Version 10.0.0 · additive Evolution über v7 Kompendium (vollständig erhalten)

Duktus: Kompendium der Heroik V3.3 · Plattform: Fusion Hero OS v10.0.0

Autor/Operator: Stephan Hagen Urban · Stand: 2026-07-15

BCG — Backward Compatibility Guarantee

Dieses Werk ist streng rückwärtskompatibel zur v7-Kompendium-Fassung:

- 1. Gesamter v7-Text (Synthese, §§0–29, 24-Störungs-Matrix, Raum, Trajektorien, Dissertation-/Edition-Brücken) bleibt wörtlich erhalten im Abschnitt *»v7-Kern (erhalten)«*.
- 2. Neue Inhalte stehen ausschließlich in der v10-Synthese-Erweiterung und in den Teilen VII–X.
- 3. Keine Störung, keine Formel und keine ethische Grenze aus v7 wird stillschweigend gelöscht oder umbenannt.
- 4. Geltungsmarken bleiben: Satz · Bedingt · Modell · Fragment (wie Heroik-Kompendium & Code-Honesty / Proof Registry).

v10-Synthese-Erweiterung: Vier Organe, eine Verfassung

v7 kannte drei Organe: klinische Matrix, formale Brücke, philosophische Einbettung.

v10 fügt ein viertes Organ hinzu, ohne die drei zu ersetzen:

Organ	Aufgabe	v7	v10
Klinik	Verorten $Z=(K,G,S,N)+I(Z)$	✓	✓ erhalten
Formal	$\psi \blacksquare \phi$, Layer, QUBO, DMN	✓	✓ + Proof Registry
Philosophie	Hospitalismus, Rekonstruktivismus, Schamgrenze	✓	✓ + Axiome I–IV
Autopolitik	Consent, Placement, Membran, PII	—	neu

Die klinische Landkarte ohne Autopolitik riskiert, dass sensible Zustandsdaten in SaaS-Membranen oder Cluster-Logs landen, ohne Fail-Closed-Consent. Autopolitik ohne Klinik ist leere Governance. v10 koppelt beides.

Oberste Direktive (klinisch gelesen, Modell):

Erhalte und steigere die **rekonstruktive Kohärenz** und **autobiographische Kontinuität** der Person in der nicht-kommutativen Verkettung von Fluss und Schnitt (q■b) — durch kontrollierte Nothing-Bereitschaft, memetische (nicht mimetische) Heilungspfade und fail-closed Personenbezug.

Was v10 zusätzlich leistet (ohne v7 zu ersetzen)

- Mapping Heroismus-Axiome I–IV → 4D-Achsen und I(Z)
- Proof-Honesty: was in FHOS **BEWIESEN / OFFEN** ist vs. was in der Matrix **Modell** bleibt
- Consent / Stage-A/B / PII: klinische Daten nie unkontrolliert in MCP/L3
- Placement L0–L4 für Therapie-Artefakte (Phone-Journal, Mainframe, Mesh, Cluster)
- Harmonisierung & Geisterjagd (AscensionOS loadable) als optionale α■-Instrumente
- Sisyphos / CEC / Persistent cycle als Rückfall- und Regenerationsmetrik
- Crosswalk zur Dissertation **Autopoiesis und Autopolitik des Fusion Hero OS**
- Erweiterte Anti-Patterns (SaaS-als-SoT für Klinik, Diagnose-by-LLM ohne Hygiene)

Was v10 weiterhin **nicht** leistet

- Kein DSM/ICD-Ersatz
- Keine Diagnose aus Chat allein
- Kein Wirksamkeitsbeweis durch Landkarte
- Keine stillschweigende Überhöhung von OFFENEN Math-Knoten zu klinischen Gesetzen

Architektur v10 (erweitert)

Teil	Inhalt	Herkunft
0	v10-Synthese, BCG, Direktive	v10 neu
I–VI	§§0–29 MER, 24 Störungen, Raum, Trajektorien, Dissertation, Edition	v7 erhalten
VII	Axiome · Autopoiesis · Autopolitik der Klinik	v10 neu
VIII	Infrastruktur: Mesh, Consent, Placement, Connectors	v10 neu
IX	Operator-Stack v10 + Proof-Honesty-Tabelle	v10 neu

Teil	Inhalt	Herkunft
X	Glossar-Erweiterung, Checklisten, Publikationsvermerk	v10 neu

TEIL VII — Heroische Axiome, Autopoiesis und Autopolitik der Klinik (v10)

Erstes Kapitel: Axiome I–IV auf die 4D-Matrix abgebildet

Axiom	Leitsatz (kurz)	4D-Bezug	Klinische Lesart (Modell)
I 1st-Tier	Eudaimonia beginnt im Schlamm	N/K roh, S-Scham	Integration statt Verleugnung des „Teufels“; N-primäre Last nicht moralisieren
II Somatic	Körper als Hardware-Horkrux	K-Achse, Interozeption	Embodiment vor reiner G-Intervention; Panik/Somatoform ehrlich am Körper
III Psycholyse	Kontrollierter Bruch / Löwen-Stage	α ■, I(Z)-Senkung	Nur mit Indikation/Kontraindikation (Kap. 18); nie als unkontrollierte Zerstörung
IV CEC / Sisyphos	Rekursive Closure, zufriedene Wiederholung	Trajektorien Z(t), β -Rückfall	Rückfall = Rekalibrierung möglich; Persistenz der Hebe-Bewegung

Geltung: Mapping = Modell, nicht Satz. Keine Axiom-Ableitung ersetzt Leitlinien.

30.1 I(Z) und Axiom I

Hohes I(Z) bei N-primären Störungen, die als „Charakterfehler“ gelesen werden, ist ein *Scham-Overlay* (Δ_N). Axiom I verlangt: die biologische Last anerkennen, statt sie moralisch zu vernichten — sonst steigt I(Z).

30.2 Axiom II und K-primäre Pfade

Panik und Somatoform: der Körper ist Zeuge. v10-Regel: α ■-Stabilisierung K vor reiner G-Umdeutung, wenn autonomes System dominiert (vgl. v7 §3.4, §9).

30.3 Axiom III und memetische vs. mimetische Heilung

Psycholyse/Bruch ohne Stamm und ohne Hygiene erzeugt mimetische Scheinheilung (Symptomkosmetik) oder iatrogene Fragmentierung. v7 §6 bleibt bindend; v10 bindet Axiom III an §18.5 Kontraindikationen.

30.4 Axiom IV und Trajektorien

Limit-Cycle (Bipolar, OCD) und Trauma-Attraktor (PTBS) sind Sisyphe-Strukturen: der Stein rollt. α -Phasen sind Hebeversuche; β ist der Abstieg. CEC-Lesen: jede Runde soll d_I zur rekonstruktiven Kohärenz *kontraktiv* sein — Modell, empirisch zu prüfen.

Zweites Kapitel: Autopoiesis der klinischen Erkenntnis

Ein klinisches Wissenssystem ist autopoietisch, wenn es:

- 1. seine Begriffe und Profile rekursiv erzeugt und prüft (Matrix-Updates, Review),
- 2. eine Membran hat (Consent, Anonymisierung, keine unkontrollierte SaaS-SoT),
- 3. einen Anker hat (klinische Hygiene §0, Leitlinien-Vorrang bei Gefahr),
- 4. regeneriert (Edition History, Sisyphe der Revision, Proof-Honesty).

Die 4D-Matrix ist *Werkzeugorgan*, nicht Souverän über den Menschen. Der Mensch bleibt Source-of-Truth seiner Einwilligung.

Drittes Kapitel: Autopolitik: wer darf klinische Zustände wohin legen?

Placement	Erlaubt für	Verboten für
L0 Phone	Journal, Stimmung, private Capture	ungefilterte Diagnose-Labels an Dritte
L1 Mainframe	lokale Auswertung, Orchestrator, MCP *mit Consent*	stilles Training mit PII
L2 Mesh-Exit	verschlüsselte Replica ohne Klartext-PII	Klartext-Psychprofile
L3 Cluster	anonymisierte Batch-Stats, synthetische Szenarien	identifizierende Kliniktagebücher
L4 SaaS	nur membranisiert, minimiert, widerrufbar	Source-of-Truth der Identität/Klinik

Anti-Patterns (v10):

- Diagnose-by-LLM ohne Hygiene und ohne Mensch-in-the-Loop
- SaaS als alleinige Akte
- Durable Klinik-Jobs auf Cloud-Shell-Nodes
- MCP-Export von Rohjournalen ohne Stage-A Consent

TEIL VIII — Infrastruktur-Brücke Fusion Hero OS v10 (v10)

Viertes Kapitel: Module und Dateien (ehrliche Landkarte)

Modul / Artefakt	Pfad / Ort	Bezug 4D	Status
4D-Kompendium v7	03_Code/core/knowledge/..._v7_Kompendium.md	Kern	erhalten
HarmonisierungsCore	ascension_os/core/harmonisierung_module.py	α■, q■b	loadable
Geisterjagd	ascension_os/core/geisterjagd_module.py	Ghost Fixing §16.5	loadable
Consent gate	ascension_os/consent_gate.py	Autopolitik	operativ v10
Proof Registry	proof_registry.yaml	Epistemik §17.6	operativ
Mesh coordination	mesh_service_coordination.yaml	Placement	operativ
Dashboard	03_Code/Dashboard	Operator-UI	operativ
Exposure practice	exposure_practice_module	S-Exposition *ohne* echte Dritte	v9.7

Fünftes Kapitel: Consent & PII (Stage-A/B)

v10 Stage-A/B: fail-closed für personenbezogene Ops, PII-Cleanup, Persona-Scanner.

Klinische Anwendung: Jede Speicherung von Z-Profilen mit Bezug zu einer realen Person setzt expliziten Consent voraus. Default = deny.

Sechstes Kapitel: QUBO-Triage und Cluster

v7 §17.4 bleibt: welche Achse zuerst.

v10: schwere Annealing-/Batch-Jobs → L3, interaktive Triage-UI → L1. Ergebnisse fließen als *aggregierte* Hinweise zurück, nicht als Identitätersatz.

TEIL IX — Operator-Stack v10 und Proof-Honesty (v10)

Siebtes Kapitel: Erweiterte Gesamtpipeline (v7 §28 + v10)

[Gefahr?] --ja--> Standardversorgung (DSM/ICD/Notfall)
|
nein
v
[Consent?] --nein--> STOP (fail-closed)

|
ja
v
Z-Erhebung (K,G,S,N) + I(Z)-Triangulation
v
Cluster (N/S/G/K-primär) + Komorbidität (§7)
v
α■ Stabilisierung → α■ Rekonstruktion → α■ Integration
v
Memetisch? (Stamm, Embodiment, Beziehung) vs mimetisch (Kosmetik)
v
Optional: Harmonisierung / Geisterjagd / DMN-Protokoll (§18) – nur indiziert
v
Trajektorie Z(t) dokumentieren (Sisyphos-Log)
v
Edition / Matrix-Revision (BCG, kein Overclaim)

Achtes Kapitel: Proof-Honesty-Kreuztabelle (Auswahl)

Claim-Bereich	In Matrix	In FHOS Proof Registry	Lesart
Z=(K,G,S,N) Landkarte	Modell	—	Werkzeug
I(Z)=Σ\	Δi\		Modell / operationalisierbar
q■b nicht-kommutativ (Math)	Brücke	Kommutator-Antisymmetrie BEWIESEN (Algebra)	nicht = klinischer Beweis
Banach-Fixpunkt universell	—	OFFEN	nicht klinisch behaupten
parallel_anneal kleine Instanzen	QUBO-Triage-Idee	BEWIESEN (eng)	nicht Therapie-Wirksamkeit
Mutual sync / Semilattice	—	BEWIESEN (eng)	Mesh, nicht Psyche
Consent fail-closed	Autopolitik v10	Stage-A Tests	operativ

Regel: Matrix-Modelle dürfen FHOS-Beweise *inspirieren*, nicht *usurpieren*.

Neuntes Kapitel: Störungen × v10-Werkzeug (Erweiterung zu §19.3)

Störung (Auswahl)	v7-Kern	v10-Zusatz
Depression endogen	N→K, α■ med + Stamm	Axiom I gegen Moralisierung; Sisyphos-Log der Hebe-Tage
Borderline	S-Sprungfeld	Consent-strikte Journalführung L0/L1; kein LLM-Diagnose-Dump
PTBS	Trauma-Attraktor	Geolock/Trigger-Hygiene; optional exposure_practice *simuliert*
OCD	CSTC, b-Übersteuerung	QUBO-Triage: G/K-Schleife zuerst; Limit-Cycle tracken
Narzissmus	G+ i grandios	Geisterjagd auf Grandiositäts-Fixierung = Modell; Peer-Review-Ethik
Autismus Masking	I hoch bei ● nahe Z*	Axiom II Erschöpfungs-K; keine „Reparatur“ der Natur-Identität

TEIL X — Checklisten, Glossar-Erweiterung, Vermerk (v10)

Zehntes Kapitel: Kliniker-Checkliste (5 Minuten)

1. Akute Gefahr? → Standard, Matrix pausiert.
2. Consent dokumentiert?
3. Primärcluster N/S/G/K + Top-2 Komorbiditäten.
4. I(Z): wo Δ am größten (Selbst vs. Fremd)?
5. α -Phase jetzt? memetisch oder mimetisch?
6. Daten: welches Placement? PII minimiert?
7. Overclaim-Check: Satz/Bedingt/Modell/Fragment gesetzt?

Elftes Kapitel: Glossar-Erweiterung v10

Term	Kurz
Autopolitik (klinisch)	Selbstgesetzgebung über Placement, Consent, Membran für Zustandsdaten
BCG	Backward Compatibility — v7 bleibt erhalten
CEC	Co-Evolutionary Closure — kontraktive Regeneration (Modell)
Fail-closed	Ohne Consent keine personenbezogene Op
L0–L4	Placement-Tiers Edge→SaaS
Memetisch/Mimetisch	Echte vs. kosmetische Heilung (v7 §6)
SoT	Source of Truth — Klinikidentität nie allein in L4

Zwölftes Kapitel: Publikations- und Editionsvermerk v10.0.0

- Plattform: Fusion Hero OS v10.0.0
- Vorgänger: Geisteskrankheiten_4D_Matrix v7 Kompendium (vollständig eingebettet)
- Stilreferenz: Kompendium der Heroik V3.3
- Verwandt: Dissertation *Autopoiesis und Autopolitik des Fusion Hero OS* (Release dissertation-v1.0)
- Ehrlichkeit: Dieses Dokument ist ein konzeptuelles und didaktisches Werk. Es ersetzt keine ärztliche oder psychotherapeutische Leistung.

Schlusswort v10

Die Landkarte wurde nicht neu erfunden — sie wurde verfasst.

v7 gab den Raum; v10 gibt der Klinik eine Verfassung für Daten, Consent und epistemische Demut.

Der Stein der Revision wird erneut gehoben. Das ist kein Scheitern. Das ist die Form.

— Ende der v10-Erweiterungen; es folgt der vollständige v7-Kern (BCG) —

v7-Kern (erhalten — BCG)

Ab hier beginnt der vollständige Text der v7-Kompodium-Fassung (unverkürzt). Alle Abschnitte 0–29 bleiben kanonischer Bestandteil von v10.0.0.

Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix

Einordnung nach Ursachdimension — MER · KLINIK · RAUM · PHILOSOPHIE

Ausführliche Fassung im Duktus des Kompodiums der Heroik V3.3 · Juli 2026

Synthese: Drei Ebenen als ein Organismus

Drei Ebenen liegen vor, und es wäre ein Missverständnis, sie für drei Beschreibungen desselben Leidens zu halten, die man nach Belieben austauschen könnte. Sie sind vielmehr drei Organe eines einzigen Erkenntnisorganismus, von denen keines allein lebensfähig ist: Die klinische Matrix gibt dem MER seinen Anwendungsort, die formale Brücke seinen Prüfstand, die philosophische Einbettung seinen Sinn.

Die klinische Landkarte erklärt, *wo* eine Störung im Raum $Z = (K, G, S, N)$ verankert ist — sie gibt den Begriffen Körper, Geist, Seele und Natur ihren Ort in der Versorgung und damit jene Schärfe, ohne die keine Triage möglich ist. Doch die Landkarte allein kann nicht beweisen; sie kann nur verorten. Hier beginnt die Aufgabe des zweiten Organs.

Die formalen Brücken — heroische Mathematik, heroische Informatik, Neurotheologie — fragen nach dem Mechanismus jeder Verschiebung: $\Psi \blacksquare \Phi$, Layer, DMN, QUBO-Triage. Sie verwandeln das klinische „so wirkt es“ in ein nachvollziehbares „so könnte es gedacht werden“, unter expliziter Geltungsmarke. Doch auch sie stoßen an eine Grenze: Wo sie operieren, wissen sie nicht immer, *wofür* im Leben eines Menschen.

Die philosophische und dissertationelle Einbettung schließlich gibt der Landkarte Maß und Schamgrenze: Hospitalismus, Rekonstruktivismus, Schicht S/F/Ü, Edition History. Sie verhindert, dass das Werkzeug zur Autoritätsgeste wird. Und so schließt sich der Kreis — denn die Bedeutung, die der Beweis nicht liefern

kann, gibt ihm die Heroik zurück, als *Kompass, nicht als Programm*.

Vorbemerkung: Was diese Matrix leisten soll — und was nicht

Eine Landkarte der Geisteskrankheiten im MER-Rahmen soll nicht fragen, ob der MER „wahr“ ist. Sie soll zeigen, wie sich unter Bedingungen klinischer Hygiene, epistemischer Disziplin und transparenter Geltung ein Werkzeug entwickeln lässt, das Triage, Verständnis und Stigma-Analyse ermöglicht — ohne DSM-5-TR oder ICD-11 zu ersetzen.

Was die Matrix leistet:

- Verortung von Zuständen als $Z = (K, G, S, N)$ mit imaginärem Raum $I(Z)$
- Unterscheidung memetischer und mimetischer „Heilung“
- Raumdiagramme Π_{KG} und Π_{SN} sowie Trajektorien $Z(t)$
- Brücken zu Mathematik, Informatik, Neurotheologie, Dissertation und Heroismus Edition

Was sie nicht leistet:

- Diagnose aus Gespräch allein
- Leitlinienersatz
- Beweis therapeutischer Wirksamkeit durch Landkartenmetapher

Zur Lesart: Jede zentrale Aussage ist als Satz, Bedingt, Modell oder Fragment zu lesen — wie im Kompendium der Heroik und in der Dissertation *Von der Bescheidenheit zur Autorität*.

Zur Architektur dieses Bandes

Teil	Abschnitte	Inhalt
I	0–10	MER-Grundlegung, 24 Störungen, Ethik
II	11–15	Raumgeometrie, Erklärungen, Lösungsansätze
III	16–19	Heroische Mathematik, Informatik, Neurotheologie
IV	20–21	2D-Projektionen, Einzelfall-Trajektorien
V	22–24	Dissertation, Concept Space, Integration
VI	25–29	Heroismus Edition 0.6–0.7, Gesamtpipeline

■# Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix (v3 — Raum, Erklärung & Lösung (v2+v3))

Einordnung nach Ursachdimension (Körper · Geist · Seele · Natur) mit imaginärem Raum

Modellcharakter: Konzeptuelle Landkarte im MER-Rahmen — kein Ersatz für klinische Diagnostik (DSM-5-TR / ICD-11).

Review: Inhaltlich überarbeitet mit Claude-Science-Methodik (Reproduzierbarkeit, Evidenzgrad, Zitationsdisziplin).

Stand: 1. Juli 2026

Kongruent mit MER (D.4) und den vier Schulen. Die vier Dimensionen sind hier nicht N/P/S/Y, sondern die Ursachachsen: wo die Störung primär verankert ist. Der imaginäre Raum (MER D.3) markiert die Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und beobachtbarer Realität — nicht „Halluzination“ im engeren psychotischen Sinn, sondern systematische Fehlkalibrierung der inneren Landkarte.

Legende:

- K = Körper (somatisch, neurologisch, neurovegetativ, biochemisch)
 - G = Geist (kognitiv, metakognitiv, Bewertung, Informationsverarbeitung)
 - S = Seele (affektiv, relational, Bindung, Scham/Schuld)
 - N = Natur (genetisch, epigenetisch, konstitutionell, entwicklungsbiologisch)
 - Zustand: – (defizitär), 0 (adaptiv), + (überaktiv/übersteuert), ± (oszillierend)
 - i = imaginärer Raum aktiv (Δ zwischen wahrgenommenem und realem Zustand)
 - Evidenz: A = Leitlinien/konsistente Meta-Analysen; B = robuste Einzelbefunde; C = konzeptionell/MER-intern
-

I

MER · Klinische Grundlegung

Dreizehntes Kapitel: Abgrenzung & klinische Hygiene

Aspekt	MER 4D-Matrix	DSM-5-TR / ICD-11
Zweck	Ursachen-Schwerpunkte + Selbstwahrnehmungsverzerrung	Diagnose, Versorgung, Forschung
Einheit	Zustandsvektor $Z = (K,G,S,N) + I(Z)$	Kategorie/Spektrum + Schweregrad
Nutzen	Triage, Therapiewahl, Stigma-Analyse	Kodierung, Medikation, Prognose

Wichtig: Ein MER-Profil erklärt **warum** Symptome zusammenpassen; es ersetzt keine strukturierte Diagnostik. Bei akuter Gefährdung (Suizidalität, Psychose, Intoxikation) gilt klinische Standardversorgung vor Modellinterpretation.

Vierzehntes Kapitel: Übersichtsmatrix (24 Störungen + Evidenz-Schwerpunkt)

Die Spalte Evidenz bezeichnet den dominanten Erklärungspfad in der aktuellen Forschung — nicht die individuelle Genese.

Störung	K	G	S	N	i (imaginär)	Primärursache	Werkanbindung	Evidenz
Depression (endogen)	–	–	–	–	i: „es wird nie besser“	N→K (Neurotransmission) + S	A.4 Hospitalismus	A
Depression (reaktiv)	0	–	–	0	i: „ich bin schuld“	S (Verlust) → G	A.5 Verstehen fehlt	A
Bipolar I (Manie)	+	+	+	–	i: „alles ist möglich“	N→G/K (Rhythmusstörung)	A.2 reines q	A
Bipolar II	±	±	–	–	i: oszilliert	N→K/G Kreislauf	Senkai ohne Kontrolle	A
Schizophrenie	–	+	–	–	i: Realität ersetzt	N→G (Wahrnehmung/Salienz)	A.2 q■b-Zusammenbruch	A
Schizoaffectiv	–	+	–	–	i: Denken + Fühlen	N→G+S	Mischform	B

Störung	K	G	S	N	i (imaginär)	Primärursache	Werkanbindung	Evidenz
Generalisierte Angst	+	+	–	0	i: „Gefahr überall“	G (Bewertung)→K	A.9 Dichotomie gestört	A
Panikstörung	+	0	–	–	i: „ich sterbe“	K (autonom)→G	Interozeption (B-bis)	A
PTBS	+	+	–	0	i: Vergangenheit=Gegegenwart	S (Trauma)→K/G	Loch 2, Senkai rechts	A
Komplexe PTBS	+	+	–	–	i: „Welt unsicher“	S (chronisch)→N/G	Hospitalismus 2.0	A
Borderline (PS)	+	±	–	–	i: idealisieren/entwerten	S (desorganisiert)→G/K	I7, A.4	A
Narzisstische PS	0	+	–	0	i: „ich bin grandios“	G (Selbstbild)+S–	J.6, COI-2	B
Antisoziale PS	0	0	–	–	i: „Regeln gelten nicht“	N+S– (Affektregulation)	Loch 1, COI-9	B
Dependente PS	–	–	+	0	i: „allein unmöglich“	S (ängstlich)→G	A.6	B
Schizoide PS	0	0	–	–	i: „brauche niemanden“	N+S–	A.5	B
Vermeidend-selbstunsicher	–	–	–	0	i: „nicht gut genug“	S (Scham)→G	A.4	B
Zwangsstörung (OCD)	+	+	0	–	i: Ritual=Kontrolle	N→G (CST C-Schleife)	D.3	A
Autismus-Spektrum	0	±	–	–	i variabel (Masking)	N (neurodevelopmental)	A.5, COI-2	A
ADHS	+	+	0	–	i: „faul“ (Fremdzuschreibung)	N→G/K (Exekutive)	q↑ b↓	A
Anorexia nervosa	–	+	–	0	i: „zu dick“	G (Körperbild)→K	Loch 2	A
Bulimia nervosa	±	+	–	0	i: Kontrolle durch Purging	G+S→K	Senkai pervertiert	A
Substanzabhängigkeit	+	–	–	–	i: „kann aufhören“	K+S (Surrogat)	J.1, J.7	A
Dissoziation / DIS	–	–	–	0	i: Identität fragmentiert	S (Trauma)→G	A.10	B
Somatoforme Störung	+	0	–	0	i: „Körper krank“	S→K (Affektkonversion)	B-bis	B

Korrekturen gegenüber v1 (wissenschaftlich)

1. Schizophrenie: Salienz-/Netzwerkmodelle (dopaminerg, glutamaterg, immunologisch) — nicht monokausal „Dopamin“.
2. Autismus: „kein i“ verworfen; Masking, soziale Fehlattriution und alexithymiebedingte Selbstunschärfe als i variabel.
3. Persönlichkeitsstörungen: ICD-11 dimensional betont; MER liefert Zusatzachse, nicht Klassifikationsersatz.
4. OCD: CSTC-Modell explizit; Ritual als b-Übersteuerung mit q-Angsttreiber.

Fünftezehntes Kapitel: Der imaginäre Raum nach Dimension

Der imaginäre Raum ist nicht eine fünfte Dimension, sondern eine Verzerrungsschicht über jeder der vier. Pro Dimension kann die Selbstwahrnehmung von der Realität abweichen:

Dimension	Realer Zustand	Imaginärer Zustand	Beispiel
K (Körper)	gesund (0)	„ich bin krank“ (+)	Somatoforme Störung
K (Körper)	mager (–)	„ich bin zu dick“ (+)	Anorexie
G (Geist)	normal (0)	„ich bin grandios“ (+)	Narzisstische PS
G (Geist)	fähig (0)	„ich bin dumm/faul“ (–)	Depression, ADHS (Fremdzuschreibung)
S (Seele)	allein (–)	„ich brauche niemanden“ (0)	Schizoide PS
S (Seele)	gebunden (0)	„niemand liebt mich“ (–)	Borderline
N (Natur)	genetisch belastet (–)	„das ist Charakterschwäche“ (0)	Stigmatisierung aller N-bedingten Störungen

Formel: Für jede Dimension i: $\Delta i_{\text{imaginär}} = x_i(\text{wahrgenommen}) - x_i(\text{real})$

→ $\Delta = 0$: akkurate Selbstwahrnehmung

→ $\Delta > 0$: Überschätzung (Grandiosität, „ich bin gesund“)

→ $\Delta < 0$: Unterschätzung (Scham, „ich bin kaputt“)

Die Gesamtverzerrung: $I(Z) = \sum |\Delta i_{\text{imaginär}}|$ — je höher, desto weiter ist die innere Landkarte von der Realität entfernt.

Operationalisierung (Claude Science): $I(Z)$ kann approximiert werden durch Triangulation aus (a) Selbstbericht-Skalen, (b) Fremdbeurteilung (Stamm/Therapeut), (c) Verhaltensmarker. Ein „realer“ Zustand ist nie direkt beobachtbar — nur konsensuelle Näherung. Inter-Rater-Reliabilität ist die zentrale Validitätsfrage (vgl. Abschnitt 5).

Sechzehntes Kapitel: Cluster nach Primärursache

3.1 N-primär (Natur-bedingt: genetisch, neurologisch, konstitutionell)

Störungen, deren Wurzel in der biologischen Ausstattung liegt. Therapie muss *durch* den Körper gehen (Medikation, Embodiment), nicht nur *am* Geist arbeiten.

→ Schizophrenie, Bipolar I/II, Autismus-Spektrum, ADHS, OCD, endogene Depression, Antisoziale PS (Amygdala), Schizoide PS

Imaginärer Raum: N-primäre Störungen werden gesellschaftlich am stärksten als „Charakterfehler“ fehlattribuiert → Δ_N imaginär: der Betroffene hält Natur für Schuld.

3.2 S-primär (Seele-bedingt: Bindung, Trauma, Beziehung)

Störungen, deren Wurzel in der Bindungsgeschichte liegt. Therapie muss *durch* den Stamm gehen (Buch 2), nicht nur *am* Individuum.

→ Borderline, Komplexe PTBS, PTBS, Dependente PS, Vermeidend-selbstunsichere PS, Reaktive Depression, Dissoziation, Essstörungen (Anteile)

Imaginärer Raum: S-primäre Störungen erzeugen die stärksten Verzerrungen im Liebesspektrum (R1–R8): der Andere wird idealisiert/entwertet/vermieden, nie akkurat gesehen.

3.3 G-primär (Geist-bedingt: kognitive Muster, Bewertung, Denken)

Störungen, deren Wurzel in der Informationsverarbeitung liegt. Therapie muss *am* Denkmuster arbeiten (KVT, Schema-Therapie), der Körper ist Sekundärschauplatz.

→ Narzisstische PS (Selbstbild), Generalisierte Angst (Bewertung), Anorexie (Körperbild), Bulimie (Kontrollillusion)

Imaginärer Raum: G-primäre Störungen haben den *größten* imaginären Raum — das Denken ist das Organ, mit dem man sich selbst beobachtet, und wenn es verzerrt, verzerrt alles.

3.4 K-primär (Körper-bedingt: somatisch, autonom, biochemisch)

Störungen, deren Wurzel im Körper liegt, ohne primär genetisch zu sein. Übergang zu N fließend.

→ Panikstörung (autonomes Nervensystem), Somatoforme Störung (Affekt → Körper), Substanzabhängigkeit (Neuroadaptation)

Imaginärer Raum: K-primäre Störungen erzeugen die stärkste Körper-Halluzination: der Körper sendet Signale, die der Geist fehlinterpretiert, oder der Geist projiziert auf den Körper, was die Seele nicht verarbeiten kann.

Siebzehntes Kapitel: Kongruenz mit dem Werk

MER/Werk-Konzept	Psychiatrische Anwendung
$Z^* = (0,0,0,0)$	Kein Mensch ist bei $(0,0,0,0)$ — das Ideal ist asymptotisch (ER-Rekursion)
$d(Z, Z^*)$	Schweregrad der Störung = Summe der Abweichungen über alle 4 Dimensionen
memetisch/mimetisch	Echte Heilung vs. symptomkosmetische Anpassung (SSRI ohne Stamm = mimetisch)
α (rekonstruktiv)	Therapie, Stamm, Embodiment, Psycholyse
β (regressiv)	Rückfall, Trigger, alte Muster
Eskalationslogik	Triage: größte Abweichung zuerst
$q \blacksquare b$	Manie = reines q; Zwang = reines b; Gesundheit = $q \blacksquare b$
Imaginärer Raum	$I(Z) = \Sigma$
Fünfte Schule (Natürlichkeit)	Unterscheiden, ob die Ursache in N (Biologie) oder G/S (Erfahrung) liegt — Voraussetzung jeder sinnvollen Therapie
Hospitalismus 2.0 (A.4)	Depression/Angst bei materiellem Überfluss = S-Mangel bei K/G-Übersättigung

Achtzehntes Kapitel: Grenzen des Modells (präzisiert)

1. Fließende Cluster: Schwerpunkte, keine Schubladen — Komorbidität ist die Norm (siehe §7).
2. Individuelle Gewichtung: Derselbe ICD-Code kann unterschiedliche MER-Vektoren tragen.
3. Messproblem $I(Z)$: Gelöst als *Triangulation*, nicht als Einzelwahrheit — epistemische Demut eingebaut.
4. Kulturelle Bindung: K/G/S/N-Begriffe sind MER-Semantik; klinische Übersetzung braucht lokalen Kontext.

Neunzehntes Kapitel: Komorbiditäts-Interaktionsmatrix (neu)

Häufige Bündel — Pfeil = Verstärkung / Koppelung:

Bündel	Wechselwirkung	MER-Dynamik	Klinische Konsequenz
ADHS + Borderline	Impuls $\uparrow$ + Bindung oszilliert	$q \uparrow + S \text{---}$	DBT + Strukturierung, Stammarbeit priorisieren
Depression + Angst	Erregung + Niedergeschlagenheit	$G + K + S \text{---}$	SSRI/SNRI + KVT; nicht nur eines behandeln

Bündel	Wechselwirkung	MER-Dynamik	Klinische Konsequenz
PTBS + Substanz	Vermeidung + Surrogat	S- → K+	Traumafokus + Entzug parallel (stabilisieren zuerst)
OCD + Depression	Ritual erschöpft	b↑ q↑ S-	EX/RP vor tiefer Rekonstruktion wenn akut
Autismus + Angst	Sensorik + Unsicherheit	N + G+	Anpassung Umwelt, nicht „Normalisierung“
Essstörung + Borderline	Kontrolle + Bindung	G+ S-±	Spezialisierte ED-Therapie + Bindungsmodul

Regel: Komorbidität erhöht I(Z) überadditive, wenn imaginäre Räume sich gegenseitig stabilisieren (z. B. „ich bin faul“ + „niemand versteht mich“).

Zwanzigstes Kapitel: Neurobiologische Pfade (kompakt, evidenzorientiert)

Cluster	Kernpfade	Evidenz
N-primär	Dopamin/Serotonin, circadiane Gene, Konnektom-Reife	A
S-primär	HPA-Achse, Amygdala-Präfrontal-Kopplung, Epigenetik früher Stress	A
G-primär	Default-Mode / Salienz-Netzwerk, kognitive Schemata	A
K-primär	Interozeption, autonomes Nervensystem, Entzugssyndrome	A

MER übersetzt diese Pfade in therapeutische Zugänge: N→pharmakologisch/Embodiment; S→Bindung/Stamm; G→KVT/Schemata; K→Psychoedukation/Interozeption.

Einundzwanzigstes Kapitel: Therapiepfade nach Cluster (Leitlinien-Nähe)

Cluster	Erstlinie	MER-Ziel	Memetisch vs. mimetisch
N-primär	Medikation + Psychoedukation + Struktur	d(Z,Z*) senken via K/N	SSRI allein ohne S/G = mimetisch
S-primär	Traumatherapie, DBT, Bindungsarbeit	Δ_S und I(Z) reduzieren	Symptomunterdrückung ohne Beziehung = mimetisch
G-primär	KVT, Metakognition, Exposition	q■b rebalancieren	Affirmation ohne Realitätsabgleich = mimetisch

Cluster	Erstlinie	MER-Ziel	Memetisch vs. mimetisch
K-primär	Interozeptive Exposition, Entzug, Somatik	K-Signal dekodieren	Sedierung ohne Bedeutungsarbeit = mimetisch

Zweiundzwanzigstes Kapitel: Ethik, Stigma & Sprache

- Person-first: „Mensch mit Schizophrenie-Erfahrung" vor reduzierender Labelidentität.
- N-Cluster: Gesellschaftliche Fehlattribution (Charakter) = Δ_N imaginär auf Populationsebene.
- Kein Wettbewerb des Leidens: MER dient Verständnis, nicht Hierarchisierung von Diagnosen.

Dreiundzwanzigstes Kapitel: Memetisch/Mimetisch-Kongruenzen

Jede Störung hat zwei Gesichter: eine echte (memetische) und eine simulierte (mimetische) Form — und ebenso jede Heilung. Die Unterscheidung ist klinisch entscheidend: mimetische Heilung stabilisiert die Oberfläche und lässt den Kern verrotten.

6.1 Matrix: Störung × Qualität × Beispiel

Störung	Memetische Form (echt, lebendig)	Beispiel	Mimetische Form (simuliert, Surrogat)	Beispiel
Depression (endogen)	Echte Trauer über realen Verlust; der Schmerz hat einen Gegenstand und einen Boden	Ein Elternteil stirbt; die Trauer ist bodenlos, aber sie gehört zu etwas	Anhedonie ohne erkennbaren Anlass; das Gefühl „nichts fühlen" als Dauerzustand, der sich selbst reproduziert	Jugendlicher in materieller Fülle, der „einfach nichts mehr fühlt" — Hospitalismus 2.0 in Reinform
Depression (reaktiv)	Eine Krise zwingt zur Neuorientierung; der Zusammenbruch hat eine Richtung	Jobverlust führt zu echtem Hinterfragen der eigenen Werte — Karfreitag	Selbstmitleid-Schleife ohne Handlung; die Krise wird zur Identität	„Ich bin halt depressiv" als Dauerstatus, der jede Veränderung blockiert
Bipolar I (Manie)	Kreative Hochphase mit echtem Output; q-Denken, das in der Welt landet	Beethovens Kompositionsphasen; der Senkai-Boost in seiner produktiven Hälfte	Grandiosität ohne Substanz; Projekte werden angefangen und nie vollendet, „alles ist möglich"	Nächtelanges Schreiben von Manifesten, die am Morgen unlesbar sind — reines q ohne b
Schizophrenie	*(kein memetisches Äquivalent im klinischen Sinn)*	—	Das Wahnsystem als vollständiger Realität ersatz; der imaginäre Raum hat die reale Welt komplett überschrieben	Stimmen, die als realer empfunden werden als die Stimme des Therapeuten

Störung	Memetische Form (echt, lebendig)	Beispiel	Mimetische Form (simuliert, Surrogat)	Beispiel
Generalisierte Angst	Echte Wachsamkeit in realer Gefahr; der Körper reagiert angemessen auf Bedrohung	Soldat im Einsatz; die Angst schützt	Dauererregung ohne Gegenstand; der Körper reagiert auf eine Gefahr, die nicht da ist	Herzrasen im Supermarkt — die Dichotomie der Kontrolle (A.9) ist zerbrochen: alles fühlt sich änderbar und bedrohlich zugleich an
PTBS	Das Trauma wird durchgearbeitet und verändert den Menschen — posttraumatisches Wachstum (Senkai links)	Veteran, der durch die Erfahrung zu einem tieferen Verständnis von Gewalt und Frieden kommt	Das Trauma wird eingefroren und wiederholt sich endlos — die Vergangenheit ist Gegenwart	Flashbacks: der Körper wiederholt den Moment, ohne dass der Geist ihn einordnen kann — Karfreitag ohne Ostern
Borderline PS	Intensive, echte emotionale Tiefe; die Fähigkeit, Bindungen mit extremer Hingabe zu leben	Künstler, deren Werk aus der emotionalen Amplitude schöpft — Frida Kahlo	Oszillation zwischen Idealisierung und Entwertung; die Bindung ist Surrogat, weil sie nie den Anderen als Anderen sieht	Partner wird in der ersten Woche zum Seelenverwandten erklärt, in der dritten zum Feind — R1 ohne R2 gesund
Narzisstische PS	Echtes Selbstvertrauen auf Grundlage realer Kompetenz; das Ego dient dem Werk	Chirurg, der weiß, dass er gut ist, und deshalb operiert — Exzellenz auf der heroischen Ebene	Grandiosität als Kompensation innerer Leere; das Ego ist die Fassade eines unbewohnten Hauses	CEO, der sich für unersetzlich hält und die Firma in den Ruin treibt — O'Reilly 2014, J.6
Antisoziale PS	*(kein memetisches Äquivalent)* — Empathielosigkeit hat keine echte Form	—	Instrumentalisierung anderer ohne innere Regung; der Andere ist Mittel, nie Zweck	Betrüger, der Opfer „aufrichtig“ als dumm betrachtet — R5 permanent Ich-Es
Dependente PS	Echte Dankbarkeit und Loyalität gegenüber einem Stamm, der hält	Kind, das sich an verlässliche Eltern lehnt — sichere Bindung (I7)	Klammern an jeden, der bleibt, ohne Prüfung ob der Andere gut ist	Frau, die beim gewalttätigen Partner bleibt, weil „allein schlimmer wäre“ — A.6 Versorgen statt Befähigen
Schizoide PS	Echte Introversion mit reicher Innenwelt; der Rückzug ist gewählt und fruchtbar	Philosophen-Typ, der in der Einsamkeit denkt und schreibt — Nietzsche in Sils-Maria	Emotionale Taubheit als Schutzwall; der Rückzug ist nicht gewählt, sondern erstarrt	Mensch, der „niemanden braucht“, aber nachts nicht schlafen kann — i: „ich brauche niemanden“, Realität: S = —
Autismus-Spektrum	Kognitive Empathie als bewusst gelerntes Werkzeug; Systemdenken als Stärke	Forscher, der Muster sieht, die anderen entgehen, und gelernt hat, sie zu übersetzen — Sprecherposition des Werks	Wenn die Umgebung die kognitive Kompensation für „echte Empathie“ hält und nie den Unterschied bemerkt	Hochfunktionaler Autist, der soziale Skripte perfekt spielt, aber innerlich leer dabei bleibt — mimetische Normalität
ADHS	Hyperfokus als q-Kraft; die Fähigkeit, in einem Thema zu versinken und Unerwartetes zu finden	Programmierer, der 16 Stunden am Stück an einem Problem arbeitet und die Lösung findet, die kein b-Denker sieht	Reizsuche als Dauerunruhe; der Hyperfokus springt, ohne zu landen	47 offene Browser-Tabs, keiner fertig gelesen — q ohne jedes b

Störung	Memetische Form (echt, lebendig)	Beispiel	Mimetische Form (simuliert, Surrogat)	Beispiel
Anorexie	Bewusster Reizverzicht und Informationsdiät (Buch 1.1); der Körper als Werkzeug der Disziplin	Faster, der den Hunger als Prüfung wählt und weiß, wann er aufhört — Senkai links	Hungern als Kontrollillusion; der Körper wird zum Feind, der besiegt werden muss	38 kg, BMI 14, „ich bin zu dick“ — der stärkste K-imaginäre Raum aller Störungen, Münzer-Logik am eigenen Skelett
Substanzabhängigkeit	Kontrollierter Substanzgebrauch in rituellem Kontext; die Substanz dient der Erfahrung, nicht der Flucht	Schamanistische Tradition mit Psilocybin in strukturiertem Setting — q durch b gerahmt	Sucht als Surrogat für Bindung; die Substanz ersetzt den Stamm	Insulin-Chat (J.7): Cannabis → Bodybuilding → „ohne Rücksicht auf Moral und Gesetz“ — Eskalation in vier Schritten, weil kein Gegenleser da war
Zwangsstörung	Echtes Ritual als Ordnungsgeber; die Wiederholung hat Sinn und Abschluss	Morgenmeditation, Trainingsroutine, Schachvorbereitung — D.2 als gesunder Zwang	Ritual ohne Abschluss; die Wiederholung wird zum Selbstzweck, der Sinn ist verloren	Händewaschen 47 Mal, weil die Zahl stimmen muss — reines b, das sich selbst frisst
Dissoziation / DIS	Rollenflexibilität; die Fähigkeit, in verschiedenen Kontexten verschiedene Seiten zu zeigen	Therapeut, der im Gespräch ganz anders ist als privat — gesunde Kontextsensitivität	Identitätsfragmentierung ; die Teile kennen einander nicht mehr	Persönlichkeitsanteile, die einander widersprechen und keine gemeinsame Geschichte haben — A.10 Dreischritt blockiert: Verinnerlichung unmöglich, weil kein durchgehendes Selbst da ist
Somatoforme Störung	Echte Körpersignale, die auf unverarbeitete Emotionen hinweisen; der Körper als ehrlicher Bote	Magengeschwür bei chronischem Stress — der Körper sagt, was der Geist verschweigt (interozeptiv, B-bis)	Symptome ohne organischen Befund, die sich verselbständigen haben; der Körper „halluziniert“ Krankheit	Jahrelange Arztodyssee ohne Befund — i: K = +, Realität: K = 0, die Ursache sitzt in S

6.2 Memetische vs. mimetische Heilung

Die Unterscheidung gilt nicht nur für die Störung, sondern ebenso für ihre Behandlung:

	Memetische Heilung (echt)	Mimetische Heilung (Surrogat)
Depression	Stamm aufbauen, Mangel benennen, Quant durchlaufen (D.2)	SSRI ohne Therapie — Serotonin auffüllen, ohne die Ursache zu berühren (J.1: SSRI-Massenverschreibung)
Angst	Dichotomie der Kontrolle wiederherstellen (A.9): was änderbar ist, ändern; was nicht, bejahen	Benzodiazepine — chemische Löschung des Signals, das eigentlich informiert
Narzissmus	Echte Reibung im Stamm; Freund, der widerspricht und bleibt (Buch 2.2)	Coaching-Industrie, die das Ego „stärkt“ statt es zu kalibrieren — Spiegel statt Freund
Sucht	Clean werden + Stamm + Psycholyse — der dreifache Weg (Buch 1.1 + 1.2 + 2.3)	Substitution ohne Beziehungsarbeit — ein Surrogat ersetzt das andere
PTBS	Trauma durcharbeiten (Karfreitag) bis zur Verinnerlichung (Ostern) — der Vierschritt	Vermeidungsstrategie als „Stabilisierung“ — der Karfreitag wird umgangen, Ostern kommt nie

	Memetische Heilung (echt)	Mimetische Heilung (Surrogat)
Borderline	Bindung als Übungsfeld, nicht als Schlachtfeld; Schematherapie als geleiteter Vierschritt	Medikation der Symptome (Stimmungsschwankungen), ohne die Bindungsstruktur (I7) zu berühren

6.3 Regel

Memetische Heilung verändert den Zustandsvektor $Z(t)$. Die Distanz $d(Z, Z^*)$ sinkt real.

Mimetische Heilung verändert den imaginären Raum. Der Mensch *glaubt*, näher am Ideal zu sein ($\Delta i \downarrow$), aber $Z(t)$ bleibt, wo es war. Die Distanz sinkt nur auf der inneren Landkarte, nicht in der Wirklichkeit.

Formel: Memetische Heilung: $d(Z(t+1), Z^*) < d(Z(t), Z^*)$. Mimetische Heilung: $I(Z(t+1)) < I(Z(t))$, aber d unverändert.

Das ist die schärfste Fassung der Surrogat-Kritik aus A.4/A.5, angewandt auf die Psychiatrie: die ganze Apparatur kann echt heilen oder nur die Oberfläche stabilisieren. Der Zufriedenheitsquant misst das eine, die Symptomcheckliste das andere. Und die Frage, welches von beiden der Therapeut misst, ist die fünfte Schule — der Abgleich zwischen Norm (Symptombefreiheit) und Ideal (echtes Verstehen).

Stand: 16. Juni 2026 — 16 Störungen mit memetisch/mimetisch-Kongruenzen und je einem konkreten Beispiel. 6 Heilungspaare. Regel formalisiert.

II

Raum · Erklärung · Lösung

Vierundzwanzigstes Kapitel: Der psychiatrische Raum: Geometrie der 4D-Matrix

Abbildung — 01 4D Raum Ueberblick. Modell, kein DSM-Ersatz.

11.1 Koordinatensystem

Jeder Mensch ist ein Zustandsvektor im vierdimensionalen Ursachenraum:

$Z = (K, G, S, N)$

Achse	Raumrichtung	Negative Richtung (–)	Null (0)	Positive Richtung (+)
K	vertikal-somatisch	Erschöpfung, Unterregulation	homöostatische Ruhe	Hyperarousal, Übererregung
G	kognitiv-informativ	Denkhemmung, Grübeln ohne Output	klare Informationsverarbeitung	Racing Thoughts, Überbewertung
S	relational-affektiv	Bindungsmangel, Scham, Isolation	tragfähige Bindung	Klammerung, emotionale Überflutung
N	konstitutionell-tief	genetische/entwicklungs biologische Belastung	ausgewogene Konstitution	(selten +; eher Modulationsdefizit)

Kodierung für Berechnung: – = –1, 0 = 0, + = +1, ± = oszillierend (Bahn zwischen –1 und +1).

Idealpunkt: $Z^* = (0, 0, 0, 0)$ — nicht erreichbar, aber Attraktor der Rekonstruktion (ER-Rekursion).

Schweregrad im Raum:

$d(Z, Z^*) = |K| + |G| + |S| + |N|$ (Skala 0–4 im Symbolsystem, höher bei $\pm$ -Oszillation als Mittel der Amplitude)

11.2 Der imaginäre Raum als Schattenhülle

Z_{real} und $Z_{\text{wahrgenommen}}$ sind zwei Punkte im selben Raum. Der imaginäre Raum ist der Verschiebungsvektor:

$$\Delta = Z_{\text{wahrgenommen}} - Z_{\text{real}} = (\Delta K, \Delta G, \Delta S, \Delta N)$$

$$I(Z) = |\Delta K| + |\Delta G| + |\Delta S| + |\Delta N|$$

Interpretation:

→ $I(Z) = 0$: innere Landkarte = konsensuelle Realität (selten dauerhaft)

→ $I(Z)$ hoch, $d(Z, Z^*)$ moderat: „gesund wirkend“, innerlich stark verzerrt (Masking, Hochfunktionalität)

→ d hoch, I niedrig: sichtbare Krise, aber ehrliche Selbsterkenntnis (günstiger für Therapie)

→ d hoch, I hoch: doppelte Entfremdung — Symptom *und* falsche Selbstdeutung (schwierigster Fall)

11.3 Raumregionen (Octanten)

Region	typisches Z-Profil	Dominante Dynamik	Beispiel-Störungen
R■ Niedrig-N	N–, K–, G–	Konstitutionelle Belastung + Erschöpfung	endogene Depression, Schizophrenie (chron.)
R■ Hoch-G/K	G+, K+, S–	Erregung ohne Bindungsausgleich	GAD, Panik, Manie (Phase)
R■ S-Defizit	S–, G–	Bindungsbruch → kognitive Einsturzspirale	reaktive Depression, Vermeidung
R■ G-Übersteuerung	G+, S–, K±	Selbstbild/Kontrolle frisst Relation	Anorexie, Narzissmus, OCD
R■ Oszillationsbahn	± auf G/K, S–	Limit-Cycle zwischen Polen	Borderline, Bipolar II
R■ Trauma-Attraktor	S–, K+, G+	Vergangenheit zieht Gegenwart zurück	PTBS, komplexe PTBS
R■ N-Entwicklung	N–/±, S–, G±	Neurodevelopmental + soziale Reibung	Autismus, ADHS
R■ K-Surrogat	K+, S–, G–	Körper ersetzt Bindung	Substanz, somatoform

11.4 Trajektorien $Z(t)$

Störungen sind keine statischen Punkte, sondern Bahnen:

→ Bipolar: Ellipse oder Limit-Cycle zwischen R■ (Manie) und R■ (Depression)

- Borderline: Sprünge zwischen S+ (Idealisierung) und S— (Entwertung) bei konstantem G+
- PTBS: Trigger springt Z(t) zurück entlang gespeicherter S-Kurve (Loch 2)
- OCD: kleine Schleife in G+/b-Raum — Ritual senkt kurzfristig Angst, erhöht langfristig d(Z,Z*)
- Heilung: Trajektorie mit α -Drift Richtung Z* — nicht geradlinig, sondern mit Rückfallvektoren β

Fünfundzwanzigstes Kapitel: Raumkarte: 24 Störungen als Koordinaten

Legende Koordinaten: -1 / 0 / +1 / ± (osz.)

Störung	Z = (K,G,S,N)	Region	d(Z,Z*)	typ. I(Z)	Raum-Metapher
Depression (endogen)	(-, -, -)	R■	4	mittel: „nie besser“	Tiefe Senke, alle Achsen nach unten
Depression (reaktiv)	(0, -, 0)	R■	2	hoch: „meine Schuld“	Sturz nach S-Einsturz, G folgt
Bipolar I Manie	(+, +, -)	R■	3	sehr hoch: „alles möglich“	Spitze außerhalb des Raster, q-Flug
Bipolar II	(±, ±, -)	R■	3–4	oszillierend	Pendel zwischen zwei Senken
Schizophrenie	(-, +, -)	R■ ∩ G+	3	maximal: Realitätersatz	G-Achse bricht aus, N-S-Kollaps
Schizoaffektiv	(-, +, -)	R■ + R■	3	hoch, dual	Zwei Attraktoren überlagert
GAD	(+, +, 0)	R■	3	hoch: Gefahr überall	Dauerhafte Erregungswolke
Panikstörung	(+, 0, -)	R■ (K-führend)	2	akut hoch: „Sterben“	Impuls-Spike auf K-Achse
PTBS	(+, +, 0)	R■	3	hoch: Zeit kollabiert	Trauma-Wellen im S-K-Plane
Komplexe PTBS	(+, +, -)	R■ + R■	4	sehr hoch	Verdichtetes Trauma-Feld
Borderline	(+, ±, -)	R■	3–4	hoch, oszillierend	Sprungfeld im S-G-Plane
Narzissmus	(0, +, 0)	R■	2	sehr hoch: Grandiosität	G-Spiegel ohne S-Rückkopplung
Antisozial	(0, 0, -)	R■ (S-)	2	mittel: Regeln extern	Kalte N-S-Ebene
Dependent	(-, -, +)	R■ (invertiert S)	2	hoch: Hilflosigkeit	An S-Achse nach außen geklebt
Schizoid	(0, 0, -)	R■	2	hoch: „brauche niemanden“	Abgeschottetes Volumen
Vermeidend	(-, -, 0)	R■	3	hoch: Scham	Schrumpfung Richtung Null

Störung	Z = (K,G,S,N)	Region	d(Z,Z*)	typ. I(Z)	Raum-Metapher
OCD	(+,+,0,-)	R■ (b-dominiert)	3	hoch: Ritual=Kontrolle	Geschlossene G-K-Schleife
Autismus	(0,±,-,-)	R■	2-3	variabel (Masking)	Andere Geometrie, nicht Defizit
ADHS	(+,+,0,-)	R■+R■	3	Fremdzuschreibung	Diffuser q-Drift, schwaches b
Anorexie	(-,+, -,0)	R■	3	maximal auf K: Körperbild	K-G-Spiegel inversion
Bulimie	(±,+, -,0)	R■+R■	3	Kontroll-Oszillation	Zyklus Purge ↔ Verlust
Substanz	(+,-, -, -)	R■	3	„kann aufhören“	K-Surrogat-Tunnel
DIS	(-,-, -,0)	R■	3	Identität split	Mehrere Z-Punkte parallel
Somatoform	(+,0,-,0)	R■	2	K nach oben, S unten	Affekt → K-Projektion

Sechszwanzigstes Kapitel: Vertiefende Erklärungen

13.1 N-Achse: Wenn die Konstitution die Bühne setzt

Mechanismus: N-primäre Störungen verändern die Empfindlichkeit der anderen Achsen, nicht nur ihren Ausgangswert. Ein N– bei Schizophrenie bedeutet: Salienzfilterung fehlerhaft → irrelevante Reize werden zu G+ (Wahrnehmungsüberlastung). Autismus: N– bedeutet anderes Sampling der Realität — nicht weniger Realität.

Imaginärer Raum: Gesellschaft setzt Δ_N : „du bist faul/schuldig“ statt „du hast ein neurobiologisches Profil“. Das verschiebt Z_wahrgenommen auf G– oder S– und verschlimmert d(Z,Z*) ohne Biologie zu ändern.

13.2 S-Achse: Bindung als gravitationsfeld

Mechanismus: S ist kein „Gefühl“, sondern die kopplungsstärke zwischen Selbst und Stamm. S– bedeutet: kein regulierender Andere verfügbar → G muss allein regulieren (Grübeln, Kontrolle, Zwang) → K folgt (Schlaf, Cortisol, Herz).

Borderline im Raum: nicht „zu viel Gefühl“, sondern fehlende Dämpfung der S-Oszillation — der Andere wird zum gesamten Koordinatensystem.

PTBS im Raum: Trauma speichert eine Geometrie — bestimmte Reize sind S- und K-Vektoren, die Z(t) sofort auf alten Punkt setzen (Flashback = Teleportation im Raum).

13.3 G-Achse: Das Meta-Instrument und sein Blindspot

Mechanismus: G beobachtet K, S, N — aber mit sich selbst als blindem Fleck. G-primäre Störungen haben deshalb maximalen I(Z): das Werkzeug der Selbstkorrektur ist das verzerrte Element.

→ Narzissmus: G+ ohne S-Rückkopplung — kein echter Gegenleser (COI-2)

→ Anorexie: G definiert K neu — $K_{\text{real}} = -$, $K_{\text{wahrgenommen}}$ invertiert

→ OCD: G generiert b-Rituale zur Angstsenkung — kurzfristig $\Delta G \downarrow$, langfristig Schleife

13.4 K-Achse: Der Körper als ehrlicher Zeuge — oder als Bühne

Mechanismus: K lügt selten allein; K „lügt“, wenn S nicht sprechen darf. Somatoform: S+ (Affekt) → K+ (Symptom) ohne Organpathologie. Panik: K+ echt → G interpretiert katastrophisch → S- (Alleingelassenheit).

Substanz: K wird durch Surrogat kurzgeschlossen — Bindungsdefizit (S-) wird nicht gefühlt, weil K+ künstlich gesetzt wird.

13.5 Schlüsselstörungen — Integrative Erklärung

Schizophrenie: Z in R■ mit G-Ausbruch; I(Z) maximal weil Wahrnehmung und Selbstmodell kollabieren. q■b-Zusammenbruch: reines q (Sinnnetz ohne b-Boden).

Bipolar: Limit-Cycle — nicht zwei Krankheiten, eine Bahn. Manie = q-Exzess ohne b; Depression = b-Einsturz ohne q-Hoffnung.

Autismus: Andere Raumgeometrie in R■ — soziale Achse S hat andere Kopplungskonstante. Masking erzeugt I(Z): $Z_{\text{fremd}} \text{ wahrgenommen} \neq Z_{\text{real}}$ (Erschöpfung durch Anpassung).

ADHS: $q \uparrow$ $b \downarrow$ im MER-Sinne — Erzeugung ohne Filter. „Faul“ ist gesellschaftliches Δ_G (Fremdzuschreibung), nicht Z_{real} .

Siebenundzwanzigstes Kapitel: Lösungsansätze vertieft (rekonstruktiv)

Abbildung — 07 Dreiphasen Alpha. Modell, kein DSM-Ersatz.

Abbildung — 09 Memetisch Mimetisch. Modell, kein DSM-Ersatz.

14.1 Dreiphasen-Modell (gilt für alle Cluster)

Phase	Ziel im Raum	MER-Werkzeuge	Kriterium Erfolg
α■ Stabilisieren	$d(Z,Z^*)$ nicht weiter steigen; akute Gefahr beenden	Krisenplan, Medikation, Schlaf, Stamm-Notkontakt	keine akute Eskalation
α■ Kalibrieren	$I(Z)$ senken — Landkarte an Realität annähern	Psychoedukation, Metakognition, Spiegelung im Stamm	Δ -Schichten benennbar
α■ Rekonstruieren	$d(Z,Z^*)$ senken — $Z(t)$ Richtung Z^*	D.2 Quant, Bindungsarbeit, Embodiment, Psycholyse	memetisch: d sinkt real

β-Rückfall: Trigger verschiebt $Z(t)$ entlang alter Bahn — nicht Scheitern, sondern Geodätische Information (wo die Kurve noch steil ist).

14.2 Lösungsmatrix nach Störung

Störung	Primärer Hebel	Konkrete MER-/klinische Schritte	Was zuerst vermeiden
Depression (endogen)	N→K, dann S	Medikation + Tagesstruktur + Stamm (nicht Isolation); Embodiment (Bewegung)	„Denk positiv“ ohne K/N-Anker (mimetisch)
Depression (reaktiv)	S→G	Trauerarbeit, Verlust benennen, ein echter Gegenleser (A.5)	Schuldverstärkung, Alleinbleiben
Bipolar I	N→Rhythmus	Mood-Stabilizer, Schlafhygiene, q-Output kanalisieren (Schreiben/Bauen mit b-Abschluss)	Manie verstärken (Hyperproduktivität feiern)
Bipolar II	Oszillation dämpfen	Mood-Tracking, Trigger-Management, Senkai-Kontrolle	Nur Depression behandeln, Hypomanie ignorieren
Schizophrenie	N→G, I(Z)	Antipsychotika + strukturierte Alltagsroutinen + psychoedukative Realitätsanker	Isolation + Deutungshoheit des Wahns
GAD	G→K	KVT/Exposition + Dichotomie der Kontrolle (A.9) + Interozeption	Dauerbenzodiazepine ohne Skills
Panik	K→G	Atem/interozeptiv → kognitive Umdeutung; „nicht sterben“ entkoppeln	Vermeidung von Auslösern als einzige Strategie
PTBS	S→G/K	Stabilisierung → Traumaverarbeitung (EMDR/CPT) → Stamm-Rückkehr	Frühe Exposition ohne Sicherheit
Borderline	S±→S stabil	DBT (Skills), Schematherapie, ein verlässlicher Stamm über Zeit	Idealisierung/Entwertung im Therapiebündnis
Narzissmus	G+→G kalibriert	Reibung durch Freund (Buch 2.2), nicht Spiegel-Coaching	Ego-Verstärkung
OCD	G/b-Schleife	EX/RP + Medikation (SSRI) + Ritual-Entkopplung	Ritual als „hilfreiche Struktur“ belassen
Autismus	N-Anpassung Umwelt	Sensorik anpassen, soziale Skripte freiwillig, Stärkenpfad	Masking als Therapieziel
ADHS	q■b balancieren	Struktur extern (b), Interessenkanäle (q), ggf. Stimulanzien	Moralismus („faul“)
Anorexie	G(Körperbild)→K	Stationär bei BMI-Gefahr + Körperbild-Therapie + familiäres System	Nur Gewicht ohne G-Arbeit
Substanz	S+K	Entzug + Stamm + Psycholyse (J.1/J.7) — Surrogat ersetzen, nicht nur verbieten	Substitution ohne Bindung
DIS	S→G Integration	Phasenorientierte Traumatherapie, Identitätsanker (A.10)	Teilidentitäten gegeneinander ausspielen

Störung	Primärer Hebel	Konkrete MER-/klinische Schritte	Was zuerst vermeiden
Somatoform	S→K Dekodierung	Affekt benennen, K-Symptom als Signal lesen (B-bis)	weitere Diagnostik-Odyssee

14.3 Cluster-spezifische Rekonstruktionspfade

N-primär Pfad: Medikation → Struktur → Psychoedukation → Stigma Δ_N korrigieren → Stamm ohne Moralismus.

S-primär Pfad: Sicherheit im Stamm → Bindungsrepräsentanz reparieren → G entlasten → erst dann tiefe Rekonstruktion (Trauma).

G-primär Pfad: Metakognitive Distanz → Schemata challengen → Verhaltensexperimente → q■b-Rebalance.

K-primär Pfad: Interozeption trainieren → K-Signale entkatastrophieren → S-Affekt zulassen statt in K zu drücken.

14.4 I(Z)-Senkung: praktische Übungen (MER)

1. Spiegel-Protokoll: Selbsturteil vs. Fremdurteil (Stamm/Therapeut) — Δ pro Achse notieren
2. Körper-Realitäts-Check: K_wahr (Gewicht, Puls, Schlaf) vs. K_imaginär (Anorexie, Somatoform)
3. Gegenleser-Regel: keine große Lebensentscheidung bei $I(Z) >$ Schwelle ohne externen Spiegel
4. Stamm-Triangulation: mindestens zwei unabhängige Bezugspersonen für S-Kalibrierung
5. Quant D.2: wöchentlich $d(Z, Z^*)$ und $I(Z)$ schätzen — Trend wichtiger als Absolutwert

14.5 Memetisch vs. mimetisch — Entscheidungsbaum

Symptom besser?

- Ja, $d(Z, Z^*)$ gesunken? → memetische Heilung (weiter α ■)
- Ja, nur $I(Z)$ gesunken? → mimetische Heilung (Oberfläche – Phase wechseln)
- Nein → β -Rückfall analysieren: welche Achse zuerst?

Achtundzwanzigstes Kapitel: Bewegungsgesetze & Prognose im Raum

Gesetz	Beschreibung
Kopplungsgesetz	Schwäche auf einer Achse zieht Nachbarachsen mit (S– → G– → K–)
Trägheitsgesetz	N– ändert sich langsam; S kann schnell kippen

Gesetz	Beschreibung
Schleifengesetz	OCD, Sucht, Bulimie: lokale Minima — Ritual senkt kurzfristig d, erhöht langfristig
Stigma-Gesetz	externes Δ verschiebt Z_wahrgenommen ohne Z_real zu heilen → I steigt
Stamm-Gesetz	regulierender Stamm senkt effektives d um bis zu eine Achse (Puffer)
Heilungs-Gradient	α wirkt stärker auf die Achse mit größtem

Prognose gut: hohe Einsicht (I senkbar), ein stabiler Stamm, eine dominante Achse (nicht vier gleichzeitig kollabiert).

Prognose schwierig: hohes d + hohes I + Komorbidität + kein Stamm + Stigma auf N.

v4-Erweiterung: §§16–19 integrieren Heroische Mathematik ($\blacksquare$, $\psi\blacksquare\phi$), Heroische Informatik (Layer, QUBO, $q\blacksquare b$) und Neurotheologie (DMN, Newberg).

III

Mathematik · Informatik · Neurotheologie

Neunundzwanzigstes Kapitel: Heroische Mathematik: $\psi \leftrightarrow Z$ im epistemischen Raum ■

16.1 Isomorphie MER $\leftrightarrow$ ■

Der psychiatrische Zustandsvektor $Z = (K, G, S, N)$ lässt sich als Element $\psi \in \blacksquare$ (epistemischer Raum, Formale Mathematik II) lesen:

MER-Komponente	■-Lesart	Bedeutung
$\text{Re}(\psi)$	integrierter, relationaler Anteil	beobachtbare Achsen K+G+S in konsensfähiger Form
$\text{Im}(\psi)$	imaginärer Verschiebungsvektor Δ	$I(Z) = \backslash$
Z^*	stabiler Kern $k \in \blacksquare$	Attraktor der Rekonstruktion (Banach-Fixpunkt, Bedingt unter $\lambda < 1$)
$d(Z, Z^*)$	Abstand zum Kern	Schweregrad im Symbolsystem
$S(\psi)$	Stabilitätsfunktion	$S(\psi) = \backslash$

Kernbrücke: Hohes $I(Z)$ entspricht hohem $\|\text{Im}(\psi)\|$ — die „Schattenhülle“ (v3 §11.2) ist der imaginäre Anteil im epistemischen Raum, nicht Halluzination im engen Sinn, sondern systematische Fehlkalibrierung der inneren Landkarte.

16.2 Habituation mit Umkehr: $\psi \blacksquare \phi$ als Therapieoperator

Die zentrale Transformationsoperation der Formale Mathematik:

$$\psi \blacksquare \phi := P_C(\text{Re}(\psi) + \text{Re}(\phi) + i \cdot (\text{Im}(\psi) - \text{Im}(\phi)))$$

MER-Übersetzung auf die Phasen $\alpha \blacksquare - \alpha \blacksquare$:

Phase	■-Operation	MER-Wirkung
$\alpha \blacksquare$ Stabilisieren	Kompatibilitätsprüfung ψ, ϕ	keine Eskalation; Re-Anteile addieren (Krisenanker)
$\alpha \blacksquare$ Kalibrieren	$\text{Im}(\psi) - \text{Im}(\phi)$ — Umkehr des Imaginären	$I(Z)$ senken: Selbstbild an Realität annähern
$\alpha \blacksquare$ Rekonstruieren	Sisyphos-Zyklen mit Netto-Gewinn	$d(Z, Z^*)$ senken; β -Rückfall = kontrollierter Zyklus, kein Scheitern

[Modell] Jede erfolgreiche Spiegelung (Stamm, Therapeut, Psychoedukation) ist eine diskrete ψ ■ ϕ -Operation: der negative imaginäre Anteil wird nicht zerstört, sondern qualitativ umgekehrt und integriert (Formale Mathematik III).

16.3 Zwei Zeitdimensionen in der Therapie

Dimension	Mathematik	Klinische Lesart
t■ (linear)	binär: vorwärts/rückwärts	Krisenzeit, Medikationswirkung, akute Episoden
t■■ (quantisiert)	Stabilitätsschritte, Integrationstiefe	Anzahl notwendiger Umkehr-Operationen bis I(Z) sinkt

[Bedingt] Unter regelmäßiger Therapie: t■■ wächst auch wenn t■ stagniert (Plateau-Phasen). Borderline-Oszillation (R■): viele t■-Zyklen, wenig t■■-Fortschritt — DBT erhöht t■■ pro Zyklus.

16.4 q1b1 ↔ b2q2 und Störungsprofile

Die kontrollierte Transformation zwischen Quantisierung (q) und Binärität (b) erklärt Denkmodus-Wechsel in Störungen:

Störung	Dominanter Modus	Transformation	MER-Hebel
OCD	b2q2 (Ritual binär, Rest quantisiert)	→ q1b1 (Bedeutung öffnen)	EX/RP: Ritual-Entkopplung
ADHS	q1b1 (Impuls quantisiert, Struktur binär)	→ b2q2 (externe b-Struktur)	Kalender, Deadlines, Stamm
Bipolar Manie	q-Flug ohne b-Abschluss	→ b2q2 (Abschluss erzwingen)	Schlaf, Mood-Stabilizer, Output mit Ende
GAD	q-Überlagerung (alle Szenarien gleichzeitig)	→ q1b1 (ein Szenario wählen)	Exposition, Entscheidungsregeln
Schizophrenie	q-Überlagerung ohne Filter	→ b2q2 (Realitätsanker)	Antipsychotika + strukturierte Routinen

[Modell] Nicht-Kommutativität $[q,b] \neq 0$ (hero-guide Geltungsstand): Reihenfolge der Interventionen zählt — z.B. bei PTBS zuerst S-Stabilisierung (α ■), dann G-Arbeit (α ■), nicht umgekehrt.

16.5 Ghost Fixing und Geister-Fixierung

Bidirektionale Suche mit abnehmendem Scope (Formale Mathematik VI): negative imaginäre Anteile („Geist“) werden in realen Punkten fixiert, bis sie erschöpft sind.

MER-Protokoll I(Z)-Senkung (v3 §14.4) als Ghost-Fixing:

- 1. Δ pro Achse benennen (Fixierung)
- 2. Körper-Realitäts-Check (Re-Punkt setzen)
- 3. Gegenleser-Regel (externe ϕ einspeisen)

4. Stamm-Triangulation (bidirektionale Suche: zwei unabhängige Pfade)

[Modell] Fixierung ≠ Unterdrückung: der Geist wird nicht verleugnet, sondern an reale Punkte gebunden, bis $\text{Im}(\psi) \rightarrow 0$ auf der jeweiligen Achse.

16.6 Stabilitäts-Gradient und Heilungsprognose

$S(\psi)$ hoch ■ niedriges $d(Z, Z^*)$ + niedriges $I(Z)$ — lokales Maximum der Stabilität (Bedingt unter $\lambda > 0$ und kompatiblen Variationen).

Profil	$S(\psi)$ -Lesart	Prognose
d hoch, I niedrig	Re instabil, Im ehrlich	günstig: $\alpha \blacksquare \rightarrow \alpha \blacksquare$ direkt möglich
d moderat, I hoch	Re stabil wirkend, Im verzerrt	Masking — $\alpha \blacksquare$ länger, $\alpha \blacksquare$ verzögert
d hoch, I hoch	Doppelte Entfremdung	Ghost Fixing + Stamm zwingend
±-Oszillation (R■)	$S(\psi)$ oszilliert	Limit-Cycle — Mood-Tracking, DBT

Dreißigstes Kapitel: Heroische Informatik:
Informationsarchitektur der Störung

17.1 Layer-Stack als Behandlungsarchitektur

Die Layer-Architektur (HEROIC_SKILL.md) mappt auf den klinischen Pfad:

Layer	Informatik	MER-Behandlung
L0 Fundament	epistemische Hygiene, Schutzregeln	Krisenplan, Suizidprophylaxe, keine Diagnose aus Chat
L1 Methoden	PeerReview, FormalMathematics, Erkenntnisprozess	Evidenzgrade A/B/C, 5-D-Review vor Therapieempfehlung
L2 Operationen	ausführbare Schritte	$\alpha \blacksquare / \alpha \blacksquare / \alpha \blacksquare$ konkret, DBT-Skills, EX/RP
L3 Meta	Audits, Langzeit-Simulation	β -Rückfall-Analyse, Komorbiditäts-Check
L4 Generation	Roadmap, Optimierung	Langzeit-Rekonstruktion Richtung Z^*

[Modell] Eine Störung ist ein Layer-Vermischungsfehler: z.B. L4-Roadmap-Denken (Zukunftsangst) auf L0 (akute K-Erschöpfung) — GAD-Profil.

17.2 Δ als Kodierungsfehler

Informations-theoretische Lesart:

$\Delta = Z_{\text{wahrgenommen}} - Z_{\text{real}}$ ist der Kodierungsfehler zwischen internem Modell und konsensueller Messung.

Fehlertyp	I(Z)-Muster	Informatik-Analogon	Intervention
Rauschen	Δ oszilliert, mittlere Amplitude	intermittierender Kanal	α stabilisieren
Bias	Δ konstant auf einer Achse	systematischer Offset	α kalibrieren
Drift	Δ wächst über t	Modell veraltet	Psychoedukation + Stamm
Quantisierungsfehler	Δ springt diskret ($\pm$)	q-Modus ohne b-Abschluss	Mood-Tracking, DBT

17.3 q■b-Routing pro Cluster

[Modell] Der Nicht-Kommutator $[q,b] \neq 0$ erzwingt pfadabhängige Triage:

Cluster	q■b-Empfehlung	Reihenfolge (wegen $[q,b] \neq 0$)
N-primär	b■q (Struktur vor Exploration)	Medikation → Routine → Psychoedukation
S-primär	q dann b (Bindung öffnen, dann strukturieren)	Sicherheit → Trauma → Skills
G-primär	b■q (Schema challengen, dann Verhalten)	KVT → Exposition → q-Kanäle
K-primär	q■b (Signal lesen, dann regulieren)	Interozeption → Entzug → S-Affekt

17.4 QUBO-Triage: welche Achse zuerst?

Die QUBO-Architektur (qb_qubo.py) modelliert Multi-Achsen-Optimierung: Welche Intervention senkt $d(Z,Z^*)$ am effizientesten?

Energiefunktion (Modell):

$$E(x) = x \blacksquare Q x, \text{ wobei } x \blacksquare \in \{0,1\} = \text{„Achse i behandeln“}$$

→ $Q \blacksquare \blacksquare$ = Kosten/Nebenwirkungen der Achsen-Intervention

→ $Q \blacksquare \blacksquare$ = Kopplung (Kopplungsgesetz v3 §15: S– zieht G– mit)

[Modell] Simulated Annealing / lokale Suche findet Näherungs-Optimum — entspricht klinischer Triage (Heilungs-Gradient: größter |Wert| in d zuerst), nicht exakter Diagnose.

17.5 Bidirektionale Suche = Therapiepfad-Exploration

Formale Mathematik VI (abnehmender Scope) $\leftrightarrow$ klinisch:

1. Mehrere Startpunkte — verschiedene Erstlinien-Therapien parallel evaluieren (z.B. SSRI vs. KVT bei Depression)
2. Scope verkleinern — nach α nur noch dominante Achse behandeln
3. Schnittpunkt verfeinern — Komorbidität erkannt → kombinierter Pfad
4. Ghost Fixing — fixierte Δ -Achsen nicht wieder öffnen bis Im erschöpft

17.6 Geltungsstand der v4-Brücken (FormalMathematics)

Aussage	Kategorie	Begründung
$I(Z) = \setminus$	$\setminus$	$\text{Im}(\psi)\setminus$
$\psi \blacksquare \phi$ senkt Im bei kompatibellem ϕ	Modell	Therapie-Heuristik, nicht bewiesen
Z^* als Banach-Fixpunkt	Bedingt	unter Kontraktion $\lambda < 1$
$[q, b] \neq 0 \rightarrow$ Interventionsreihenfolge	Modell	hero-guide: Def.-abhängig
QUBO-Triage	Modell	Heuristik, qb_qubo numerisch
DMN-Hyperaktivität $\leftrightarrow$ G+ Grübeln	Bedingt	neuroimaging-Konsens, nicht MER-intern
Meditation senkt DMN-Aktivität	Bedingt	Newberg + Replikationen, kontextabhängig

Kapitel 31: Neurotheologie: DMN, Verinnerlichung & S–N-Brücke

18.1 Empirische Brücke (Newberg)

[Bedingt] Neurotheologie (Newberg u.a.): kontemplative Praxis verändert Hirnstruktur und -funktion messbar (PET/fMRI). Das ist kein Glaubensargument, sondern neurochemisches Ereignis — Buch 1.2: „Das ist kein Glaube, das ist ein CT-Scan.“

Was trägt (Ü-B1, Masterarchiv):

- Meditation und bestimmte kontemplative Praktiken deaktivieren das Default Mode Network (DMN)
- DMN-Hyperaktivität korreliert mit selbstreferenziellem Grübeln (G+), Depression, Angst
- Ähnliche DMN-Muster bei fokussierter Meditation und bei Psilocybin (DMN-Reduktion) — gleicher Mechanismus, unterschiedlicher Zugang

Was nicht trägt:

- „Weitere Zeitdimension“ als Beobachtung (Fragment — Interpretation, nicht Empirie)
- Substanz als Umgehung der Psycholyse (kollidiert mit A.10 — kein Karfreitag, kein Ostern)

18.2 DMN als Hintergrundprozess (Layer-0-Daemon)

Informations-Lesart: Das DMN ist ein permanenter Hintergrundprozess — die „Standard-Schleife“ des Selbstmodells.

DMN-Zustand	Z-Profil	Störungsnähe
Hyperaktiv	G+, S– (Einsamkeit im Kopf)	Depression, GAD, Narzissmus

DMN-Zustand	Z-Profil	Störungsnähe
Hypoaktiv / deaktiviert	$G \rightarrow 0$, K reguliert	post-Meditation, Flow, fokussierte Arbeit
Dysreguliert	$G \pm$, I(Z) hoch	Psychose, Manie, Dissoziation

[Modell] DMN-Störung ist kein eigener fünfter Achsenvektor, sondern eine G–S–K-Kopplungsstörung im bestehenden Z-Raum.

18.3 Verinnerlichung: gerichtete vs. ungerichtete Psycholyse

Buch 1.2 Unterscheidung, neurotheologisch untermauert:

Modus	Prozess	Risiko	DMN-Effekt
Ungerichtet (Passion ohne Anlass)	planloses In-sich-Graben	Einsturz, I(Z) steigt	DMN-Verstärkung, Grübel-Spirale
Gerichtet (Psycholyse)	Mangelkarte $\rightarrow$ ein Mangel $\rightarrow$ Arbeit	kontrolliert	DMN-Deaktivierung durch Fokus + Stamm-Spiegelung

MER-Operator: Gerichtete Psycholyse = $\psi \blacksquare \phi$ mit externem ϕ (Therapeut, Stamm, Ritual mit Abschluss). Ungerichtet = ψ ohne ϕ — Im(ψ) kann wachsen.

18.4 S–N-Kopplung: immanenter Sinn, transzendente Form

Concept Space D7 (Masterarchiv): *immanenter Sinn in transzendenter Form* — Inhalt diesseitig, Gestalt sakral.

Psychiatrische Lesart ohne metaphysische Zusatzachse:

$\rightarrow$ S (Bindung, Sinn, Scham) kann über K (neurale Plastizität, Meditation, Embodiment) reguliert werden

$\rightarrow$ „Transzendente Form“ = Ritual mit Abschluss (D.2 gesunder Zwang) — nicht esoterisch, sondern b-Abschluss für q-Erfahrung

$\rightarrow$ Störung: Ritual ohne Abschluss (OCD, Sucht) — reines b, das sich selbst frisst

[Modell] Kontemplative Praxis als $\alpha \blacksquare$ -Verstärker bei G-primären und S-primären Profilen — nicht Ersatz für $\alpha \blacksquare$ bei akuter Psychose oder Suizidalität.

18.5 Kontraindikationen & Indikationen

Profil	Neurotheologie-Pfad	Warnung
GAD, Depression (stabil)	MBCT, MBSR, geführte Meditation	$\alpha \blacksquare$ muss abgeschlossen sein
PTBS	nur nach S-Stabilisierung; Stamm anwesend	Trigger-Risiko bei ungeleiteter Praxis
Borderline	DBT-Mindfulness (strukturiert)	kein offenes Schweben
Schizophrenie (aktiv)	kontraindiziert als Primärintervention	Realitätsanker (b2q2) zuerst

Profil	Neurotheologie-Pfad	Warnung
Bipolar (Manie)	kontraindiziert	q-Flug verstärken
OCD	nur mit EX/RP — Ritual ≠ Meditation verwechseln	Schleifengesetz beachten

18.6 Praktisches Protokoll: DMN-Kalibrierung (α■)

[Modell] Vier Schritte, an v3 §14.4 angelehnt:

- 1. DMN-Check: „Bin ich im Kopf oder im Körper?“ — K-Achse aktivieren (Embodiment)
- 2. Fokus setzen: ein Mangel, ein Atemzug, ein Satz (gerichtete Psycholyse)
- 3. φ einspeisen: Stamm oder Therapeut spiegelt Δ nach der Praxis
- 4. b-Abschluss: Ritual beenden (nicht endlos meditieren — Schleifengefahr)

Kapitel 32: Integrationsmatrix v4: kombinierter Operator-Stack

19.1 Gesamtpipeline

Eingang: $Z(t)$, $d(Z, Z^*)$, $I(Z)$

- L0: α■ Stabilisieren (Krisenanker, Banach-Vorbedingung)
- ■: $\psi \blacksquare \phi$ + Ghost Fixing (α■, $I(Z)$ senken)
- ■■ Neurotheologie: DMN-Kalibrierung (wenn indiziert)
- Informatik: q■b-Routing + QUBO-Triage (Achsen-Reihenfolge)
- ■■ Sisyphos-Zyklen → α■ Rekonstruieren (d senken, $Z \rightarrow Z^*$)
- ■■ β-Rückfall = Geodätische Information

19.2 Erweiterte Bewegungsgesetze (v4)

Gesetz	v3	v4-Ergänzung
Kopplungsgesetz	$S \rightarrow G \rightarrow K -$	+ $[q,b] \neq 0$: Reihenfolge der Achsen-Intervention nicht vertauschbar
Schleifengesetz	Ritual senkt kurzfristig d	+ DMN-Hyperaktivität = Schleife ohne b-Abschluss
Stamm-Gesetz	Stamm senkt d	+ Stamm liefert ϕ für $\psi \blacksquare \phi$ (externer Realitätsanker)
Heilungs-Gradient	größter \	Wert\
Verinnerlichungsgesetz	— (neu)	Gerichtete Psycholyse senkt I_m ; ungerichtet erhöht I_m (Modell)

Gesetz	v3	v4-Ergänzung
DMN-Gesetz	— (neu)	DMN-Hyperaktivität stabilisiert G+-Grübeln; Deaktivierung öffnet α ■ (Bedingt)

19.3 Störungen × v4-Werkzeug-Matrix (Auswahl)

Störung	ψ ■ ϕ	q ■ b	QUBO-Priorität	DMN-Pfad
Depression (endogen)	Stamm-Spiegelung	b ■ q	$N \rightarrow K \rightarrow S$	MBCT nach α ■
GAD	Metakognition ϕ	$q \rightarrow b$ (ein Szenario)	$G \rightarrow K$	MBSR
PTBS	Trauma- ϕ (EMDR)	q dann b	$S \rightarrow G \rightarrow K$	nur geführt, nach S-Safe
OCD	EX/RP	$b2q2 \rightarrow q1b1$	G	kein freies Meditieren
Borderline	DBT-Spiegelung	S stabil q ■ b	S	DBT-Mindfulness
Schizophrenie	Realitäts- ϕ	$b2q2$	$N \rightarrow G$	kontraindiziert (aktiv)
ADHS	externe ϕ (Coach)	$q1b1 \rightarrow b2q2$	G (Struktur)	Fokus-Training

19.4 Epistemische Hygiene (L0)

- Keine der v4-Brücken ersetzt DSM-5-TR / ICD-11 oder Leitlinien
- „Transzendenz“ im MER-Sinn = Form, nicht metaphysische Diagnose
- Substanz-basierte „Erweiterung“ bleibt außerhalb des MER-Heilungspfads (Ü-B2)
- Alle $\psi \leftrightarrow Z$ -Isomorphismen sind Modelle — klinisch nutzbar, mathematisch nicht bewiesen

v5-Erweiterung: §§20–21 — 2D-Projektionen (Π_{KG} , Π_{SN}), Schattenhülle in 2D, Einzelfall-Trajektorien für 10 Störungen.

IV

Visualisierung · Trajektorien

Kapitel 33: Visuelle Raumdiagramme (2D-Projektionen)

Abbildung — 02 Pi Kg Koerper Geist. Modell, kein DSM-Ersatz.

Abbildung — 03 Pi Sn Seele Natur. Modell, kein DSM-Ersatz.

Abbildung — 04 Schattenhuelle Iz. Modell, kein DSM-Ersatz.

20.1 Projektionsprinzip

Der 4D-Raum $Z = (K, G, S, N)$ wird für Visualisierung auf zwei orthogonale Ebenen projiziert:

Ebene	Achsen	Was sie zeigt
Π_{KG}	K (vertikal) $\times$ G (horizontal)	Erregung, Denken, Kontrolle, Grübeln
Π_{SN}	S (horizontal) $\times$ N (vertikal)	Bindung, Konstitution, Tiefe, Stigma

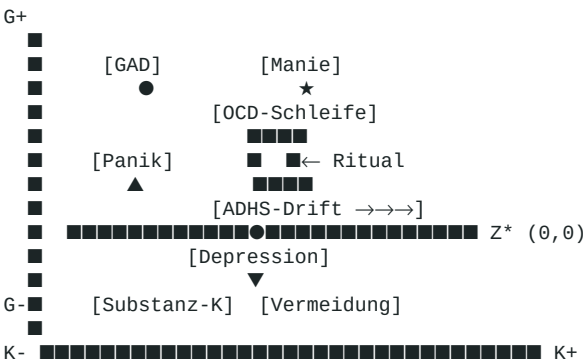
Projektion: Punkt $p_{KG} = (K, G)$ und $p_{SN} = (S, N)$. Die jeweils fehlenden Achsen erscheinen als Tiefenmarker (S/N in Π_{KG} , K/G in Π_{SN}).

Skala: $-1 \cdot 0 \cdot +1$ ($\pm$ = oszillierend zwischen den Polen)

Z^* liegt im Ursprung beider Ebenen: (0, 0).

Iso-Distanz: $d(Z, Z^*) = |K| + |G| + |S| + |N|$. In 2D sichtbar als Manhattan-Kontur um Z^* (Rhombus in der jeweiligen Projektion, unvollständig ohne die fehlenden Achsen).

20.2 Ebene Π_{KG} — Körper $\times$ Geist



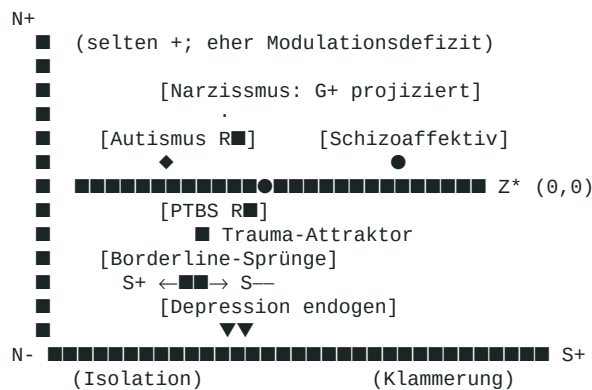
(Erschöpfung) (Hyperarousal)

Regionen in Π_{KG} :

Zone	K	G	MER-Region	Dominante Dynamik
Zentrum	0	0	Z^*	homöostatische Ruhe
Nordost	+	+	$R_{\blacksquare}$	Erregung ohne Bindungsausgleich
Südwest	–	–	$R_{\blacksquare}/R_{\blacksquare}$	Erschöpfung + Denkhemmung
Ost (G+)	$\pm$	+	$R_{\blacksquare}$	Meta-Kontrolle frisst Körper
Nord (K+)	+	0	$R_{\blacksquare}/R_{\blacksquare}$	Körper führt, Geist folgt

Iso-Kontur $d=2$ in Π_{KG} (wenn $S,N=0$): Rhombus mit Eckpunkten $(\pm 2,0)$, $(0,\pm 2)$ — in der Praxis selten isoliert, da Kopplungsgesetz $S-$ mitzieht.

20.3 Ebene Π_{SN} — Seele $\times$ Natur

Regionen in Π_{SN} :

Zone	S	N	MER-Region	Lesart
Südwest	–	–	$R_{\blacksquare}$	Konstitution + Bindungsmangel
Südost	+	–	$R_{\blacksquare}$ invertiert / Dependent	Klammerung bei N-Belastung
West	–	0	$R_{\blacksquare}/R_{\blacksquare}$	Bindungsbruch ohne N-Shift
Trauma-Loch	–	$\pm$	$R_{\blacksquare}$	Gespeicherte S-Kurve zieht zurück

20.4 Überlagerung: Schattenhülle $I(Z)$ in 2D

Wenn $Z_{\text{real}} \neq Z_{\text{wahrgenommen}}$, zeigt die Projektion zwei Punkte:

→ ● real = beobachtbares Verhalten/Konsens

→ ■ wahrgenommen = Selbstbericht

Δ -Vektor = Pfeil von ● nach ■.

Π _KG Beispiel Anorexie:

G+
 ■ K_wahr = "fett" (G definiert K)
 ■
 ▼ Δ (I hoch)
 ● K_real = - (Untergewicht)
 ■■■■■●■■■■■■■■■■ Z*
 K-■

Masking (Autismus): ● nahe Z* (funktioniert), ■ tief in R■ (Erschöpfung) — hohes I bei moderatem d.

20.5 Mermaid: Gesamtübersicht 24 Störungen

```
quadrantChart
  title Pi_KG Projektion (schematisch)
  x-axis G- --> G+
  y-axis K- --> K+
  quadrant-1 Manie: [0.75, 0.85]
  quadrant-1 GAD: [0.7, 0.65]
  quadrant-1 Panik: [0.55, 0.8]
  quadrant-1 OCD: [0.8, 0.55]
  quadrant-1 ADHS: [0.65, 0.5]
  quadrant-2 Narzissmus: [0.75, 0.1]
  quadrant-3 Depression endogen: [0.25, 0.15]
  quadrant-3 Vermeidung: [0.2, 0.2]
  quadrant-3 Substanz: [0.15, 0.35]
  quadrant-4 Z*: [0.5, 0.5]
```

```
quadrantChart
  title Pi_SN Projektion (schematisch)
  x-axis S- --> S+
  y-axis N- --> N+
  quadrant-3 Depression endogen: [0.2, 0.15]
  quadrant-3 Schizophrenie: [0.25, 0.2]
  quadrant-3 Autismus: [0.3, 0.25]
  quadrant-3 PTBS: [0.2, 0.35]
  quadrant-2 Borderline S+: [0.75, 0.3]
  quadrant-3 Borderline S-: [0.25, 0.3]
  quadrant-4 Z*: [0.5, 0.5]
```

Hinweis: Mermaid-Quadranten sind heuristische Verdichtung, keine metrische Skala.

20.6 Legende & Achsenkreuz

Gemeinsame Symbole:

Symbol	Bedeutung
●	Z_real (beobachtet)
■	Z_wahrgenommen (Selbstbericht)
★	Spitze / akute Episode
▲	Impuls-Spike
→	Drift / q-Flug
■■■	Limit-Cycle / Schleife

Symbol	Bedeutung
■	Trauma-Rückfall (Teleportation)
Z*	Idealpunkt (0,0,0,0) — Attraktor

20.7 Alle 24 Störungen in Π_{KG} und Π_{SN}

Störung	$\Pi_{KG} (K,G)$	$\Pi_{SN} (S,N)$	I(Z)-Pfeil typisch
Depression (endogen)	(−,−) SW	(−,−) SW	■ nach SW: „nie besser“
Depression (reaktiv)	(0,−) West	(−,0) West	■→S−: Schuld
Bipolar I Manie	(+,+) NO	(+,−)*	■ weit NO: Grandiosität
Bipolar II	Pendel NO↔SW	(−,−)	oszillierender Pfeil
Schizophrenie	(−,+) NW	(−,−) SW	■ maximal: Realitätersatz
GAD	(+,+) NO	(−,0) West	■ G+: Gefahr überall
Panik	(+,0) Nord	(−,−) SW	▲ K+, kurzer Δ
PTBS	(+,+) NO	(−,±) SW	■ Trigger → Trauma-Punkt
Borderline	(±,+) Ost	(±,−) Mitte	Sprünge S-Achse
Narzissmus	(0,+) Ost	(−,0) West	■ weit G+
OCD	(+,+) NO-Schleife	(0,−) West	kleine ■■■■
Autismus	(0,±) Mitte	(−,−) SW	Masking: ● Mitte, ■ SW
ADHS	(+,+) NO-Drift	(0,−) West	→ q-Drift
Anorexie	(−,+) NW	(−,0) West	Δ K invertiert
Substanz	(+,−) SW-Nord	(−,−) SW	Tunnel K+
Somatoform	(+,0) Nord	(−,0) West	K+ ohne Organ

Bipolar Manie: S+ idealisierend, in Π_{SN} oft nach Osten gezogen.

Kapitel 34: Einzelfall-Trajektorien Z(t)

Abbildung — 05 Bipolar Limit Cycle. Modell, kein DSM-Ersatz.

Abbildung — 06 Ptb's Trauma Attraktor. Modell, kein DSM-Ersatz.

21.1 Notation

→ $t_{\blacksquare}$ = Erkrankungsbeginn / Erstmanifestation

→ $\alpha_{\blacksquare}/\alpha_{\blacksquare}/\alpha_{\blacksquare}$ = Behandlungsphasen (v3 §14)

→ β = Rückfallvektor

→ Pfeile = Richtung der Bahn, nicht Geschwindigkeit

Trajektorien-Typen:

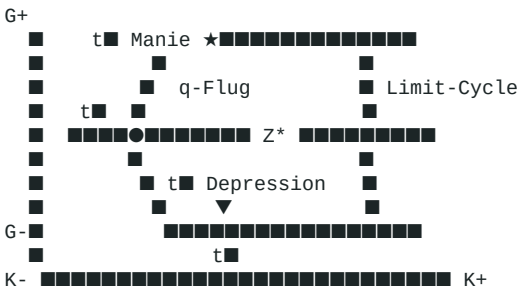
Typ	Form	Beispiel
Senke	Monoton Richtung Z^*	Depression reaktiv nach Verlust

Typ	Form	Beispiel
Limit-Cycle	Geschlossene Schleife	Bipolar II, OCD
Sprungfeld	Diskrete Teleportation	Borderline, DIS
Attraktor-Loch	Trigger zieht zurück	PTBS
Drift	Diffuse q-Bewegung	ADHS
Spirale	Schleife mit α -Drift	Heilung mit Rückfällen

21.2 Fall A — Bipolar I (Limit-Cycle + Manie-Spitze)

Profil: Z = (+,+,+,-) Manie ↔ (-,-,-,-) Depression

Π _KG Trajektorie:



Phasen:

Phase	Z(t)	d	I(Z)	Ereignis
t■	(0,0,0,0)	0	0	Baseline
t■	(+,+,0,-)	2	steigend	Hypomanie, Schlaf ↓
t■	(+,+,+,-)	3	sehr hoch	Manie, „alles möglich“
t■	(-,-,-,-)	4	mittel	Crash, b-Einsturz
t■	(-,-,-,-)	4	sinkend	α ■: Mood-Stabilizer, Schlaf

Heilung (α -Drift): Cycle schrumpft — Manie-Spitze von ★ auf kleineres ■■■, Depression-Senke weniger tief. Kriterium: d_max pro Zyklus sinkt über 12 Monate.

MER-Werkzeuge: Mood-Stabilizer (N→Rhythmus), Schlafhygiene (K), q-Output mit b-Abschluss (Schreiben/Bauen mit Ende).

21.3 Fall B — Borderline (Sprungfeld S-Achse)

Profil: Z = (+,+,S±,-) — S oszilliert zwischen + und —

Π_{SN} Trajektorie:



Π_{KG}: G+ konstant — nur S springt. Das erklärt, warum nur G-Therapie scheitert: die Bahn liegt in Π_{SN}.

Phasen:

Phase	S	G	I(Z)	Dynamik
Idealisierung	+	+	hoch	Anderer = gesamtes Koordinatensystem
Zwischenraum	0	+	sehr hoch	Verlassungsangst, G+ Grübeln
Entwertung	—	+	hoch	Scham, Impuls (K+)

α■→α■ Pfad:

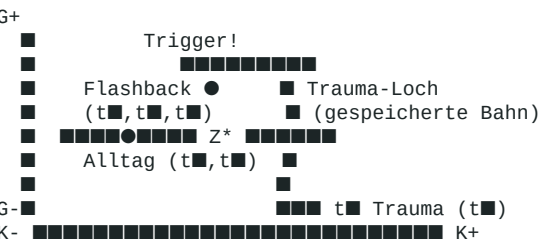
- 1. α■: DBT Skills (STOP, TIPP) — Sprung verlangsamen, nicht stoppen
- 2. α■: einen Stamm über Zeit — ϕ für ψ■ϕ stabil
- 3. α■: S-Dämpfung — Amplitude |S+| und |S-| sinken

β-Rückfall: Kontaktabbruch → sofortiger Sprung t■ ohne Zwischenraum. Geodätische Info: S-Achse noch steil.

21.4 Fall C — PTBS (Trauma-Attraktor / Teleportation)

Profil: Z ruht bei (0,-,-,0), Trigger → (+,+,-,0) in Sekunden

Π_{KG} mit Trauma-Loch:



Phasen:

t	Ereignis	Z	d	I(Z)
t■	Trauma	(+,+,-,-)	3	hoch
t■	Stabilisierung	(0,-,-,0)	2	hoch (Vigilanz)
t■	Alltag	(0,0,-,0)	1	mittel
t■	Trigger	(+,+,-,0)	3	akut hoch
t■	Recovery	(0,-,-,0)	2	„war nicht so schlimm“ (I steigt)

Heilung: Trajektorie entkoppelt — Trigger verschiebt Z weniger weit (t■ näher an Z*). EMDR/CPT = Geometrie der S-Kurve im Trauma-Loch umformen.

Warnung: α■ (Exposition) nur nach α■ S-Safe — sonst t■ verstärkt statt abschwächt.

21.5 Fall D — OCD (lokale Schleife in Π_KG)

Profil: G+/b-Ritual-Schleife, kurzfristig d↓, langfristig d↑



Ein Zyklus (Minuten bis Stunden):

1. q-Flut: „Was wenn kontaminiert?“ — G+
2. b-Ritual: Händewaschen — kurzfristig G→0, d sinkt
3. Nachklang: Ritual war „Beweis“ dass Gefahr real — I(Z)↑, Schleife enger

α■: EX/RP — in Schleife stehen bleiben ohne Ritual, bis Angst peaked und fällt (Habituation ψ■φ auf G-Achse).

21.6 Fall E — Depression endogen (Senke, alle Achsen)

Profil: Z = (-,-,-,-), monoton oder stagnierend

3D-Projektion (Π_KG + Tiefe S,N):





Reihenfolge $N \rightarrow K \rightarrow G \rightarrow S$ (QUBO: Kopplung von N -).

α ■ Pfad: Antipsychotika (N→G) + strukturierte Routinen (b2q2) + keine Isolation (S- verstärken).

Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix · v10.0.0 · BCG · mit v7-Kern · 49

Heilung: b von außen (Coach, Deadlines, Stamm) → Drift wird geführte Trajektorie Richtung Z*.

21.9 Fall H — Anorexie (K-G-Spiegel-Inversion)

Δ-Vektor dominiert:

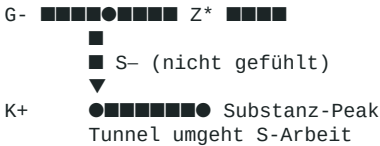


Trajektorie: Z_real driftet SW (K–), Z_wahrgenommen driftet entgegengesetzt (G definiert K neu) — I(Z) wächst während d moderat bleibt. Gefährlichstes Profil für α■: Scheinbare Einsicht (I↓) ohne K_real-Shift.

α■: Körperbild-Therapie = φ muss K_real spiegeln, nicht G-Fantasie.

21.10 Fall I — Substanz (K-Surrogat-Tunnel)

Π_KG Tunnel:



Trajektorie: Kurzer K+-Spike, dann Rückfall tiefer (S– verstärkt). Schleifengesetz wie OCD, aber Achse K statt G.

α■: Surrogat ersetzen, nicht nur verbieten — S+ durch Stamm statt K+ durch Substanz.

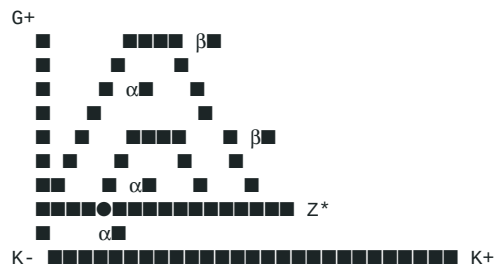
21.11 Fall J — Autismus mit Masking (Zwei-Punkt-Bahn)

Zwei parallele Trajektorien:

Bahn	Z	Sichtbarkeit
Z_fremd (Masking)	(0,0,0,–)	● nahe Z* in Π_KG
Z_real (Erschöpfung)	(–,–,–,–)	■ tief SW

Heilung: Bahnen konvergieren — weniger Δ zwischen ● und ■. Nicht: Masking verstärken.

21.12 Heilungs-Spirale (generisches Muster α + β)



Jeder β -Rückfall: kleinerer Radius als voriger Zyklus = memetische Heilung.

Kriterium: $d(Z_{\max} \text{ pro Zyklus})$ monoton sinkend über ≥ 3 Zyklen.

21.13 Trajektorien-Matrix (Kurzreferenz)

Störung	Trajektorien-Typ	Dominante Ebene	Erster α -Hebel
Bipolar I/II	Limit-Cycle	Π_{KG}	$N \rightarrow \text{Rhythmus}$
Borderline	Sprungfeld	Π_{SN}	S stabilisieren
PTBS	Attraktor-Loch	$\Pi_{SN} + \Pi_{KG}$	$S \rightarrow G$ (nach Safe)
OCD	Lokale Schleife	Π_{KG}	G/b EX/RP
Depression endogen	Senke	beide	$N \rightarrow K$
Schizophrenie	G-Divergenz	Π_{KG}	$N \rightarrow G$, b2q2
ADHS	q-Drift	Π_{KG}	externe b
Anorexie	Δ -Inversion	Π_{KG}	K_{real} anker
Substanz	K-Tunnel	Π_{KG}	$S+$ statt $K+$
Autismus	Zwei-Punkt	Π_{SN}	Δ senken
GAD	Wolke (stationär NO)	Π_{KG}	$G \rightarrow K$ Exposition
Panik	Impuls-Spike ▲	Π_{KG}	$K \rightarrow G$ Atem

21.14 Anwendung: Trajektorie lesen (Checkliste)

1. Ebene wählen: Wo liegt die Bewegung? Π_{KG} (Erregung/Denken) oder Π_{SN} (Bindung/Konstitution)?
2. Typ bestimmen: Senke, Cycle, Sprung, Loch, Drift?
3. ● und ■ markieren: I(Z) sichtbar machen
4. α -Phase zuordnen: Stabilisieren / Kalibrieren / Rekonstruieren?
5. β als Information: Wo ist die Kurve noch steil?

6. Nicht vertauschen: $[q,b] \neq 0$ — Achsen-Reihenfolge aus §17.3

v6-Erweiterung: §§22–24 — Dissertation (Schicht S/F/Ü), Heroische Philosophie (A.1–A.12, Concept Space D1–D8), integrative Landkarte.

Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix — v6 Dissertation & Heroische Philosophie

Schicht S/F/Ü · Concept Space · Fundament A.1–A.12

Ergänzt v5 (Visualisierung, Trajektorien). Quellen: Dissertation *, „Von der Bescheidenheit zur Autorität“* (Urban, 23.06.2026), *Der heroische Mensch* (Masterstruktur), Concept Space of Philosophy.

Geltungsdisziplin: Dissertation-Kern — epistemische Hygiene vor Autoritätsgeste. Jede Brücke ist Modell oder Bedingt, sofern nicht als Satz/Fragment markiert.

Stand: 1. Juli 2026

V

Dissertation · Heroische Philosophie

Kapitel 35: Die Dissertation als epistemischer Rahmen der 4D-Matrix

22.1 Drei Schichten auf dem psychiatrischen Dokument

Die Dissertation unterscheidet drei Bearbeitungsschichten — dieselbe Logik gilt für die Geisteskrankheiten-4D-Matrix:

Schicht	Dissertation	4D-Matrix-Entsprechung	Geltung
S (Substanz)	Philosophische Substanz: Analog, q■b, Hospitalismus, Verstehen, Quant	MER-Rahmen K/G/S/N, I(Z), memetisch/mimetisch, vier Schulen	Modell — klinisch heuristisch, nicht DSM-Ersatz
F (Formalisierung)	Satz/Bedingt/Modell/Fragment; ψ■φ, Banach, [q,b]≠0	v4 §§16–17: ■, QUBO, Layer, Geltungsstand-Tabelle	Bedingt/Satz wo ausgewiesen
Ü (Überschreibung)	Entkategorisierung, Modal-Kollaps, Selbst-Mythologisierung	Gefahr: Diagnose aus Chat, „Heilung“ ohne d-Senkung, Stigma-Δ	Warnschicht — was zu vermeiden ist

Hauptfrage der Dissertation (übertragen): *Durch welche Operationen verwandelt sich ehrlich begrenzte MER-Landkarte in scheinbar klinische Autorität?*

Antwort im MER-Raum:

- 1. Entkategorisierung — Evidenzgrad A/B/C streichen → jede Tabelle wirkt wie Leitlinie
- 2. Modal-Kollaps — „Modell“ wird zu „Diagnose“ (z.B. Z=(-,-,-,-) als Etikett statt Hypothese)
- 3. Metapher-als-Beweis — Trajektorien-Bilder als Prognose ohne Verlaufsdaten
- 4. Monumentalisierung — v5/v6 als „fertige Wahrheit“ statt Werkzeug

Regel (L0): Die 4D-Matrix bleibt in Schicht S+F. Schicht Ü ist die Selbstkritik — jede Anwendung muss Geltungskategorie sichtbar lassen.

22.2 Hospitalismus 2.0 ↔ psychiatrischer Raum

A.4 / Dissertation Kap. 1.2: *Quantenarmut bei Mengenüberfluss* — materiell überversorgt, tribal verhungern (Spitz).

MER-Übersetzung:

Hospitalismus	4D-Achse	Z-Profil	I(Z)
Follower, Likes, Messung	S– (Surrogat)	S–, G+	hoch: „bin verbunden“
Therapie ohne Stamm	S–	S–, G–	mimetisch: I↓ ohne d↓
Hochfunktional + isoliert	K stabil, S–	(0,0,–,0)	Masking
Algorithmus als Freund	G+ (b-Erzwingung)	G+, S–	Δ_G : System für Stamm

Formel: Hospitalismus 2.0 = $d(Z, Z^*)$ moderat, Quantendichte des Verstandenwerdens (A.7) minimal.

Der Zufriedenheitsquant (kleinster Moment des Verstandenwerdens) korreliert in der Matrix mit niedrigem d auf S-Achse bei echtem Stamm — nicht mit Symptomfreiheit allein.

22.3 q■b und die Dissertation-Router-Logik

Dissertation *q/b-Router* (extern, prüfbar) $\leftrightarrow$ klinische Triage (v4 §17.4):

Router-Entscheidung	Psychiatrie
b-lastig, leicht → small	α■ Stabilisieren: Krisenplan, Medikation, Schlaf
gemischt → mid	α■ Kalibrieren: Psychoedukation, I(Z)
q-lastig oder hart → large	α■ Rekonstruktion: Trauma, Bindung, Psycholyse

[Modell] Der Router ist kein Selbst-Akt des Patienten — externe Instanz (Therapeut, Stamm, Leitlinie) routet q/b. Phoenix-Mode-Analogie in der Dissertation = mimetische Heilung: Oberfläche integriert, Substanz unverändert.

22.4 Schicht F: was formal trägt — und was die Matrix nutzen darf

Aus Dissertation Kap. 2 + Anhang A (claimweise):

Behauptung	Dissertation-Status	Matrix-Nutzung
$[q, b] \neq 0$ (generisch)	Satz (2×2 nachgerechnet)	Interventionsreihenfolge (v4 §16.4)
Banach-Fixpunkt unter Kontraktion	Bedingt	Z^* als Attraktor (v3 §11.1)
Reziprozität $q■b■ \cdot b■q■ = \dots$	Bedingt/Definition	Stamm-Gegenseitigkeit, nicht automatisch
$\psi■\phi$ Monotonie $S(\psi■\phi) \geq \max$	widerlegt in Sandbox	MER nutzt $\psi■\phi$ als Modell, nicht Satz
$S(\psi) = \Re■^2 - \lambda \Im■^2$	Modell (Umkehr-Theorem problematisch)	$I(Z) \leftrightarrow \Im■$ — Analogie, nicht Beweis

Konsequenz: Die 4D-Matrix darf $\psi■\phi$ und Trajektorien als klinische Heuristik führen — nicht als bewiesene Therapiegesetze. Das ist die Dissertation-Lektion: *Bescheidenheit vor Autorität.*

22.5 Psycholyse und Vierschritt (A.10) im Raum

A.10 Vierschritt der Erkenntnis $\leftrightarrow$ Behandlungsphasen:

Schritt	Philosophie	MER-Phase	Raumwirkung
1 Erkennen	Mangel ins Bewusstsein	α ■ Diagnose/Insight	Z(t) benennbar
2 Hinterfragen + Konsequenz	Passion, Durcharbeitung	α ■ Kalibrieren	I(Z)↓, Δ benennbar
3 Akzeptieren + Verinnerlichen	Teil von mir	α ■ Beginn	d↓ erste Achse
4 Kooperation	Stamm, Gegenleser	α ■ Stamm-Arbeit	d↓ multi-Achse, β kleiner

Ohne Schritt 4 bleibt Heilung stumm (A.10) — memetisch nur auf einer Achse, ohne Stamm-Validierung.

Ungerichtete Psycholyse = Passion ohne Anlass = $\text{Im}(\psi)\uparrow$ (v4 §18.3, Dissertation Schicht S).

Kapitel 36: Heroische Philosophie: Concept Space ↔ 4D-Matrix

23.1 Zwei Koordinatenräume, eine Geometrie

Raum	Dimensionen	Gegenstand
Concept Space (D1–D8)	Weltanschauungen, Philosophien	Wo steht eine *Denkposition*?
4D-Matrix (K,G,S,N)	Psychische Zustände, Störungen	Wo steht ein *Mensch im Leiden*?

Brücke: Nicht Identität, sondern Projektion — philosophische Achsen erklären *warum* bestimmte Z-Profile stabil sind und *welche* Fehlattritionen (Δ) gesellschaftlich vorprogrammiert sind.

23.2 Achsen-Mapping D1–D8 → K/G/S/N

Concept-Space-Achse	Pol / Werk-Position	4D-Matrix-Abbildung
D1 Substrat Analog↔Diskret	Analog (A.1)	Kontinuierliche Z(t)-Bahnen; ± = noch nicht geschnitten
D2 Stoff Ma↔Ge	Ma~ (naturalistisch)	K+N primär; G als Meta-Instrument, nicht Idealismus
D3 Erkenntnis Em↔Ve	Em~ (empirisch getönt)	Evidenzgrade A/B/C; Newberg = Em-Anker
D4 Wahrheit Re↔Ko	Rk Rekonstruktivismus	I(Z)-Senkung = Rekonstruktion der Landkarte, nicht naive Realität
D5 Locus Pe·St·Sy	Dreistufig (A.3)	S=Stamm, G=Person-Meta, System = externes Δ (Stigma)
D6 Ethik Tu	Arete (A.6)	Therapie = Tugendpfad, nicht Pflichtdeontologie (kein „du musst gesund werden“)
D7 Sinn Im/Tr	Immanent in transzendenter Form	S-Achse + Ritual mit b-Abschluss (v4 §18.4)
D8 Notwendigkeit De + amor fati	Determinismus → Handlung (A.9)	β-Rückfall bejahren; Sisyphe-Zyklen mit Netto-Gewinn

23.3 Der heroische Mensch als Koordinate — und als Patient

Eigenposition (Concept Space v1): An · Ma~ · Em~ · Rk · Pe·St·Sy · Tu · Im/Tr · De

Psychiatrische Lesart ohne Selbstverherrlichung:

Philosophische Festlegung	Gesundes Z-Profil	Pathologische Verzerrung
Rekonstruktivismus (D4)	I(Z) senkbar, α ■ möglich	Narzissmus: G+ ohne Rückkopplung — rekonstruiert nur Selbstbild
Pe·St·Sy (D5)	S reguliert, G kalibriert	Ebenenvermischung: System-Logik im Stamm (Kälte) oder Stamm-Logik im System (Verrat)
Arete (D6)	Bewährung im Stamm	Perfektionismus: G+ frisst K (Anorexie, OCD)
amor fati (D8)	β als Information	Resignation: d hoch, keine α ■ — falscher Determinismus

Nachbarn im Concept Space (Aristoteles, Nietzsche, Stoa, Hegel) = therapeutische Traditionen, nicht Heilsversprechen: Stoa → K-Interozeption; Aristoteles → Tugendpfad; Hegel → Dreischritt als Verlaufsform.

23.4 A.3 Ebenenvermischung als Krankheitsursache

Vermischung	Pathologie (A.3)	4D-Matrix
Person ohne Stamm	Narzissmus	G+, S-, I(Z) hoch
Stamm im System	Kollaps	Borderline-Bündnis: Idealisierung des Therapeuten
System im Stamm	Kälte, Verrat	„Diagnose“ als Identität (Stigma-Gesetz)

Heilung in philosophischer Sprache: *Jede Logik an ihren Ort* = QUBO-Triage + [q,b]≠0 — nicht alles gleichzeitig auf allen Achsen.

23.5 A.12 Die drei Schnitte — klinische Kampfgrößen

Zu groß	Schnitt (A.12)	4D-Matrix
Die Seele	der Quant (ein Mangelfeld)	Eine Achse pro α -Zyklus, nicht vier gleichzeitig
Das big other	vier Institutionen	Eine Institution pro Buch-3-Kapitel — nicht „das System“ pauschal
Die Anderen	Geliebter/Freund/Stamm	S-Triangulation: ein Stamm-Kontakt zuerst

Regel: Begriffe so groß wie das Verstehen, so klein wie die Tat — verhindert Ü-Schicht-Inflation in der Selbstdeutung.

24.2 Störungen × Philosophie × Dissertation (Auswahl)

Störung	Concept-Space-Nähe	Philosophischer Kern	Dissertation-Warnung
Depression	Camus (Im), Stoa (De)	Mangelfeld-Iteration (A.8), Quant	SSRI ohne S = mimetisch = Entkategorisierung
Narzissmus	Nietzsche (Tu, Pe) — Gegner wenn ohne Stamm	Person ohne Stamm (A.3)	Grandiosität = Ü-Autoritätsgeste
Borderline	Kierkegaard (Pe)	S-Oszillation, Vierschritt ohne 4	Idealisierung Therapeut = Stamm-im-System
Schizophrenie	—	q ohne b (A.2)	Keine „weitere Dimension“ (Ü-B1)
OCD	Kant (Pf) — Gegner auf D6	b frisst q	Ritual als Struktur ≠ EX/RP
PTBS	—	Trauma-Geometrie (Loch 2)	Frühe Exposition = Modal-Kollaps
Autismus	—	Andere Geometrie (R■), nicht Defizit	Masking als Therapieziel = I↑
GAD	Hume (Em)	q-Überlagerung aller Szenarien	„Positive Denken“ = mimetisch

24.3 Klinischer Pfad mit philosophischer und dissertationeller Prüfung

1. L0 Schicht Ü vermeiden: Evidenzgrad sichtbar lassen
2. Z(t) in Π_{KG} / Π_{SN} verorten (v5)
3. Concept-Space- Δ : welche gesellschaftliche Fehlattribution? (D4, D5)
4. A.12 Schnitt: ein Mangelfeld, ein Stamm-Kontakt
5. q/b-Router: $\alpha■ \rightarrow \alpha■ \rightarrow \alpha■$ (Dissertation Router)
6. $\psi■\phi$ als Modell: Spiegelung, nicht Beweis (Schicht F)
7. Vierschritt A.10: Kooperation (Stamm) vor Abschluss
8. Prüfung: d gesunken? (memetisch) oder nur I? (mimetisch)

24.4 Was die Dissertation der Matrix verbietet

Verbot (Schicht Ü)	MER-klinische Entsprechung
Entkategorisierung	MER-Profil ohne „Modell/konzeptionell“
Modal-Kollaps	„Borderline ist S+“ als Wesen, nicht als Moment
Selbst-Mythologisierung	„Heilung durch Matrix allein“
Monumentalisierung	v6 als fertiges Lehrgebäude
Phoenix-Mode	Symptomunterdrückung ohne d-Senkung

24.5 Was die heroische Philosophie der Matrix gibt

Gabe (Schicht S)	Klinischer Gewinn
Hospitalismus 2.0	S-Achse, Surrogat-Diagnose
Verstehen (A.5)	Kernfrage aller Mangelfelder
q■b (A.2)	Denkmodus-Störungen (ADHS, OCD, Manie)
Vierschritt (A.10)	Phasenmodell + Psycholyse-Richtung

Gabe (Schicht S)	Klinischer Gewinn
Rekonstruktivismus (D4)	I(Z)-Arbeit als philosophisch fundiert
amor fati (A.9)	β-Rückfall nicht moralisieren

24.6 Epistemische Schlussformel

Die Geisteskrankheiten-4D-Matrix ist kein Kapitel der Dissertation und kein Ersatz für Philosophie — sie ist eine klinische Projektion des heroischen Werks unter Schicht-S+F-Disziplin:

, „Weder bloße Metaphorik noch ein fertiges Lehrgebäude. Ein ehrlicher Zwischenstand.“

— Kompendium der Heroik V3.3 / Dissertation Einleitung

Für die Praxis heißt das: Landkarte nutzen, Geltung markieren, Stamm einbeziehen, d messen.

v7-Erweiterung: §§25–29 — Heroismus Kritische Gesamtedition 0.6–0.7, Genese April–Juli 2026, Mapping Philosophie ↔ Technik ↔ MER.

VI

Heroismus Edition · Gesamtarchitektur

Kapitel 38: Heroismus Edition History: Versionsarchiv

25.1 Editionslinie (ab 0.6)

Edition	Datum	Inhalt	Status
0.6	01.07.2026	Redaktionsprinzipien, Leitthese, Kap. 1 Historische Genese (1.4.–1.7.2026), Kap. 2 Architektur Hero Fusion OS, 7-Teile-Plan	konsolidiert
0.7	01.07.2026	+ Mapping-Tabelle Philosophie ↔ Technik; Versionshistorie in versions/	current
4D-Matrix v7	01.07.2026	Integration Edition History in MER-Psychiatrie (dieses Kapitel)	Ergänzung

Archivstruktur (ZIP):

- versions/Heroismus_v0.6_2026-07-01.pdf
- versions/Heroismus_v0.7_2026-07-01.pdf
- Heroismus_Kritische_Gesamtedition_current.pdf (= 0.7)

Redaktionsregel der Edition: Keine Vorgaben überschreiben; Ergänzungen transparent kennzeichnen — identisch mit Schicht-Ü-Warnung der Dissertation (v6 §22.1).

25.2 Leitthese (Edition 0.6) — auf die 4D-Matrix bezogen

Die kritische Edition untersucht nicht, ob die Heroik „wahr“ ist, sondern wie sich unter Bedingungen hoher Intensität ein Korpus entwickelt, der gleichzeitig Untersuchungsgegenstand, Fallstudie, Werkzeug und technische Manifestation ist.

Übertragung MER:

Edition-Leitthese	4D-Matrix-Entsprechung
Untersuchungsgegenstand	Z(t) als beobachtbare Bahn, nicht als moralisches Urteil
Fallstudie der Genese	β-Rückfall + Ostern-Psycholyse als dokumentierter Prozess
Operatives Werkzeug	α■–α■, Π_KG/Π_SN, Trajektorien

Edition-Leitthese	4D-Matrix-Entsprechung
Technische Manifestation	Fusion Hero OS: geisteskrankheiten_4d_v*.json, Training, Parallel-Optimizer

Zeitraum 1.4.–1.7.2026 korreliert mit der Genese der Matrix selbst (v2 Claude Science → v3 Raum → v4 Brücken → v5 Visual → v6 Dissertation → v7 Edition) — rekonstruktivistisch doppelt: Dokument rekonstruiert Rekonstruktion.

25.3 Historische Genese — drei Phasen ↔ klinische Analogie

Phase (Edition Kap. 1)	Ereignis	MER-Lesart (Modell)
1 Vorbereitung (1.–20.4.)	6-tägige Psycholyse Ostern; High-Intellect-Protokoll	α■ Kalibrierung: I(Z)↓, Stamm-Kontakte↑; L0 epistemische Hygiene
2 Verdichtung (Ende April–Mai)	RE-Synthese, Sisyphos, Buchprojekt „Heroismus“, Memes	q■b-Balance; Theorie→Praxis = memetische Heilung (d↓)
3 Konsolidierung (Juni–1.7.)	Kritische Edition, Hero Fusion OS, 3-Schritt-Zyklen	Schicht F; Versionskontrolle = Audit Trail

Psycholyse Ostern 2026 (Edition): dialektische Auflösung, somatischer Verankerungsmechanismus — in der Matrix: gerichtete Psycholyse (v4 §18.3, v6 §22.5), nicht Substanz-Umgehung (Ü-B1).

Coal Canary (Selbstbild): warnende Instanz ohne Kapitulation — MER: hohes d, aber I(Z) ehrlich (günstigeres Profil für α■).

Kapitel 39: Mapping-Tabelle: Edition 0.7 erweitert um MER-Psychiatrie

26.1 Konsolidierte Tabelle (Edition 0.7 + MER-Ergänzungen)

Philosophisches Prinzip	Technisches Modul (Edition)	4D-Matrix / Klinik (v7)	Geltung
Sisyphos-Zyklus (kontrollierte Level-Drops)	Self-Update Protocol + Rollback + Audit Trail	β-Rückfall als Geodätische Info; Heilungs-Spirale (v5 §21.12)	Modell
Psycholyse (dialektische Löwen-Auflösung)	Evolver + Reasoning Threads + Peer-Review 5D	α■: ψ■φ, gerichtete Psycholyse; ungerichtet = Im↑	Modell
Christus-Prinzip (somatische Internalisierung)	Memory Layer + Closure + Persistent State	α■: Verinnerlichen (A.10 Schritt 3); Ritual mit b-Abschluss	Modell
Teufel / 1st-Tier (deskriptive Naturkomponente)	Raw Input Layer + Disruptor-Logging	Rohe K+/G+-Impulse nicht sofort pathologisieren (Panik, Manie-Phase)	Modell
Stage-9 (Kosmozentrisch)	Layer 6 ω Fixed-Point + Multi-Layer Validation	Z* als Attraktor; Schicht F Banach Bedingt	Bedingt

Philosophisches Prinzip	Technisches Modul (Edition)	4D-Matrix / Klinik (v7)	Geltung
Hyper-Threading	Hyper-Threading Engine + Cross-Thread Fusion	parallel_internal_optimizer.py — 6 Tracks; Multi-Achsen-Triage	Modell
Rekonstruktivistische Transparenz	Audit + Versionsapparat + Peer-Review	Geltungsstand-Tabelle; Edition History; Evidenz A/B/C	Modell
Hospitalismus 2.0 (A.4)	— (Edition: via Heroik-Korpus)	S– Surrogat; Quantenarmut ↔ d moderat, Quant minimal	Modell
q■b (A.2)	q/b-Router (qb_router.py)	q■b-Routing pro Cluster (v4 §17.3); OCD/ADHS/Bipolar	Modell
MER 4D-Matrix	geisteskrankheiten_4d_v*.json + Training data.jsonl	Z=(K,G,S,N), I(Z), Π_KG, Π_SN, Trajektorien	Modell
Dissertation Schicht S/F/Ü	Claude Science + FormalMathematics	v6 §22: Entkategorisierung = klinische Ü-Gefahr	Modell
Concept Space D1–D8	Concept_Space_of_Philosophy_v1.md	v6 §23: philosophische Δ-Erklärung	Modell
Neurotheologie / DMN	—	v4 §18: MBCT nach α■; Kontraindikationen	Bedingt

Hinweis Edition 0.7: Tabelle erfindet keine neuen theoretischen Inhalte — MER-Zeilen sind explizit als v7-Ergänzung gekennzeichnet.

26.2 Layer 6 ω → Layer 0 ↔ Behandlungsstack (Kap. 2 Architektur)

Edition Kap. 2 definiert: Layer 6 ω → Layer 0, Hyper-Threading, Selbstmodifikation, epistemische Garantien.

Fusion-OS-Layer	Edition-Funktion	MER-Behandlung (v4 §17.1)
Layer 6 ω	Ultimate Fixed-Point, Validation	Z* — nicht erreichbar, Attraktor
Layer 4	Generationale Ordnung	Langzeit-Rekonstruktion, Roadmap
Layer 3	Meta-Audit	β-Analyse, Komorbidität, Supabase-Events
Layer 2	Operationen	α■/α■/α■ konkret
Layer 1	Methoden-Module	Peer-Review 5D, FormalMathematics, Claude Science
Layer 0	Fundament	Krisenplan, keine Diagnose aus Chat, Schicht Ü

26.3 Redaktionsprinzipien ↔ Matrix-Geltung

Edition-Prinzip	Matrix-Umsetzung
Vollständigkeit	v2–v7 kumulativ, nicht ersetzen
Konsistenz	Kongruenz mit Dissertation, Masterstruktur, Concept Space
Transparenz	Evidenzgrade, Schicht S/F/Ü, Edition-Vermerk
Wissenschaftliche Sorgfalt	Satz/Bedingt/Modell/Fragment

Edition-Prinzip	Matrix-Umsetzung
3-Schritt-Zyklen (Konsolidieren–Erweitern–Revision)	v2→v3→...→v7 = Erweitern; Build-Scripts = Revision

Kapitel 40: Geplante 7-Teile-Edition ↔ 4D-Matrix-Dokument

Edition 0.6 sieht sieben Teile vor — die v7-Vollausgabe mappt darauf:

Teil (Edition)	Inhalt	4D-Matrix-Abschnitte
I Rekonstruktion	Historische Genese	§25 Genese; Ostern-Psycholyse
II Heroik	RE, Axiomatik, Psycholyse	§22–23 Philosophie; §26 Mapping
III Formalisierung	Mathematik, Quantenkognition	§16–17 v4; Schicht F
IV Hero Fusion OS	Architektur, Agenten	§26 Layer; Parallel-Optimizer
V Wissenschaftstheorie	Bedingungen der Möglichkeit	Dissertation Schicht S/F/Ü
VI KI-Epistemologie	Halluzinationsprävention	Schicht Ü; Claude Science offline
VII Diskussion	Anwendungen, offene Fragen	§24, §27; Pädagogik/Stigma

Anhänge Edition: Versionsapparat = dieses ZIP + geisteskrankheiten_4d_v7.json; Register = 24 Störungen + 10 Trajektorien.

Kapitel 41: Klinischer Pfad mit Edition-Historie

Abbildung — 08 Gesamt Pipeline. Modell, kein DSM-Ersatz.

28.1 Vollständige Pipeline (v2–v7)

HEROISMUS EDITION 0.7 (Transparenz, Audit)
■
DISSERTATION Schicht S/F/Ü (v6)
■
PHILOSOPHIE A.1–A.12 + Concept Space (v6)
■
4D-MATRIX Z, I(Z), d (v2–v3)
■
 ψ ■ ϕ · Layer · QUBO · DMN (v4)
■
 Π _KG · Π _SN · Trajektorien (v5)
■
EDITION MAPPING · Genese · Versionen (v7)

28.2 Was die Edition der Matrix verbietet (kumulativ mit Dissertation)

Edition / Ü	Klinische Fehlanwendung
Monumentalisierung der Edition	„Heroismus Edition beweist Heilung"
Autonome Edition ohne Autor-Check	Korrekturen ignorieren (Kap. 1 Rekonstruktionshinweis)
Stage-9 als erreichter Patientenzustand	Z* verwechseln mit „gesund"
Memes als Therapieersatz	Coal Canary statt Stamm
3-Schritt-Zyklus ohne α ■	Revision ohne Stabilisierung

28.3 Nächste Editionsschritte (aus 0.7) ↔ Matrix-Roadmap

Edition nächster Schritt	Matrix-Entsprechung
Mapping-Tabelle erweitern (Axiomatik 1.24, Quantenkognition)	v8: formale Mathematik tiefer
Kap. 2 in formale Gesamtstruktur	Layer-Dokumentation vollständig
Versionshistorie ausbauen	v7.1, v7.2... datiert in versions/
Autor-Korrekturen Kap. 1	Selbstbericht-Register (Loch 10)

Kapitel 42: Epistemischer Editionsvermerk

**„Weder bloße Metaphorik noch ein fertiges Lehrgebäude."* — Kompendium V3.3 / Dissertation*

**„Die kritische Edition untersucht nicht, ob die Heroik wahr ist."* — Heroismus Edition 0.6 Leitthese*

Die Geisteskrankheiten-4D-Matrix v7 ist Teil VII (Diskussion) und Anhang (Versionsapparat) der Heroismus-Kritischen Gesamtedition — klinisches Werkzeug unter Edition-0.7-Transparenz:

- 1. Landkarte nutzen (Z, Π _KG, Π _SN)
- 2. Geltung markieren (Edition + Dissertation + FormalMathematics)
- 3. Stamm einbeziehen (Vierschritt 4, Psycholyse gerichtet)

4. d messen (memetisch vs. mimetisch)

5. Version dokumentieren (v7 = Edition History eingeflochten)

*Ende v7 — Heroismus Edition History. Kombinierbar mit v6–v2. Quelle:
Heroismus_Edition_History.zip.*

Schluss: Zur Lesart — vier Arten von Aussagen

Satz. bewiesen oder mit zitierbarer Quelle — selten in der klinischen Matrix.

Bedingt. gilt unter expliziten Annahmen (z.B. Banach unter $\lambda < 1$).

Modell. heuristische Landkarte — der Normalfall dieser Ausgabe.

Fragment. offen, unvollständig — ehrlich markiert, nicht vertuschen.

*Weder bloße Metaphorik noch ein fertiges Lehrgebäude. Ein ehrlicher Zwischenstand. —
Kompendium der Heroik V3.3, übertragen auf die MER-Psychiatrie.*

— Ende · Geisteskrankheiten in der 4D-Matrix · v10.0.0 · BCG · mit v7-Kern —